

# Jak działa system

Rezerwacja wizyt · Fundacja Niepodzielni

**Do czego służy ten dokument.** Opisuje, co system robi z perspektywy osób, które będą z niego korzystać: pacjenta, psychologa i koordynatora. Nie ma tu terminów technicznych ani opisu, jak to zbudować — na to jest osobny dokument.

Przy każdym kroku opisujemy też, **co dzieje się w tle**: kiedy wychodzi mail, kiedy SMS, co się blokuje i kiedy pieniądze zmieniają właściciela. To ta część, która najczęściej wraca w telefonach od pacjentów.

Sporządzono piątek, 7 sierpnia 2026, 12:09 na podstawie działającej makiety.

# Jak to przebiega krok po kroku

---

*Najczęstsze sytuacje w systemie, od początku do końca. Prawa kolumna pokazuje, co system robi sam, bez udziału człowieka.*

## Pierwsza rezerwacja przez nową osobę **PACJENT**

Ktoś, kto pierwszy raz szuka pomocy, chce znaleźć wolny termin i mieć go potwierdzony od razu — bez zakładania konta, bez telefonu i bez czekania na odpowiedź.

### 1 Wchodzi na listę wolnych terminów

Pacjentka widzi wszystkich specjalistów w jednym widoku, ułożonych od tego, kto przyjmie najszybciej. Przy każdym nazwisku od razu widać cenę i pierwsze wolne godziny — nie trzeba wchodzić w profil, żeby sprawdzić, czy ktoś ma cokolwiek wolnego. Może zawęzić listę: rodzaj wizyty, online albo stacjonarnie, „termin w ciągu 48 godzin”, albo wpisać nazwisko, obszar pomocy czy nurt.

#### SYSTEM W TLE

Nic nie wysyła. Kalendarz pokazuje 30 dni w przód i nie pokazuje godzin wcześniejszych niż 2 godziny od teraz.

### 2 Wybiera specjalistę i godzinę

Na profilu widzi biogram, obszary pomocy, podejście do pracy, opinie i kalendarz na najbliższe 7 dni. Wybiera rodzaj konsultacji — niskopłatna za 55 zł, pełnopłatna za 115–145 zł, asystent zdrowienia bezpłatnie albo diagnoza ADHD za 350 zł — i klika godzinę. Cena zmienia się na miejscu, bez przeładowania strony.

#### SYSTEM W TLE

Od kliknięcia w godzinę termin jest trzymany dla niej przez 10 minut. Przez ten czas nikt inny go nie zarezerwuje.

### 3 Podaje dane do wizyty

Wpisuje imię i nazwisko, e-mail i telefon oraz zaznacza, czy była już wcześniej w fundacji. Może zostawić kilka zdań o tym, z czym przychodzi — to pole nie jest obowiązkowe. Nad formularzem stoi zdanie, po co potrzebny jest adres: na niego pójdzie potwierdzenie, link do spotkania i przypomnienia.

#### SYSTEM W TLE

Zegar 10 minut cały czas biegnie i jest widoczny w podsumowaniu po prawej stronie.

### 4 Decyduje, czy chce konto

Domyślnie rezerwuje jako gość i nic nie musi wybierać. Może zaznaczyć „Założ mi konto przy tej rezerwacji” i ustawić hasło — wtedy sama zmienia terminy, zapisuje się na grupy i widzi historię wizyt. Jeśli tego nie zrobi, konto i tak powstanie w tle, a ona wejdzie do niego linkiem z maila.

#### SYSTEM W TLE

Konto powstaje dopiero po zaksięgowaniu płatności. Dane do logowania idą w tym samym mailu co potwierdzenie, nie osobno.

### 5 Zaznacza zgody i potwierdza zasady odwołania

Dwie zgody są wymagane: regulamin z polityką prywatności oraz zgoda na przetwarzanie danych o zdrowiu. Trzecia, o warsztatach i grupach wsparcia, jest nieobowiązkowa. Osobno, na żółtym tle, potwierdza, że zna zasady odwoływania — z wypisaną konkretną datą i godziną, do której odwołanie jest bezpłatne.

#### SYSTEM W TLE

Nic nie wysyła. Data graniczna jest wyliczona z terminu wizyty: dokładnie 24 godziny wcześniej.

## 6 Płaci

Przycisk pokazuje kwotę wprost: „Zapłać 145 zł i zarezerwuj”. Płatność idzie przez Stripe — karta, BLIK, Google Pay albo Apple Pay. Fundacja nie przechowuje danych karty.

### SYSTEM W TLE

Po zaksięgowaniu płatności system wysła jednocześnie dwie rzeczy: mail „Potwierdzenie wizyty” z terminem, nazwiskiem specjalisty, formą, miejscem albo linkiem, numerem rezerwacji i datą graniczną bezpłatnego odwołania, oraz SMS „termin zarezerwowany, szczegóły wysłaliśmy mailem, nr rezerwacji”. W SMS-ie nie ma ani nazwy usługi, ani słowa o zdrowiu.

## 7 Widzi potwierdzenie

Na ekranie jest numer rezerwacji, dane wizyty, potwierdzenie kwoty i — przy wizycie online — link do spotkania od razu, do skopiowania. Przy wizycie stacjonarnej w tym samym miejscu stoi adres z piętrem, numerem gabinetu i domofonem. Jest też przycisk dodania wizyty do kalendarza w telefonie i propozycje trzech kolejnych terminów: ten sam dzień i godzina za tydzień, dwa i trzy tygodnie.

### SYSTEM W TLE

Nic więcej nie idzie w tym momencie. Każdy z kolejnych terminów, jeśli je wybierze, to osobna rezerwacja i osobna płatność.

## 8 Dostaje przypomnienia przed wizytą

Ekran potwierdzenia mówi wprost, co się jeszcze wydarzy, żeby pacjentka nie musiała pilnować niczego sama. Dzień przed przychodzi przypomnienie z ostatnim momentem na bezpłatną zmianę. Dwie godziny przed wizytą online przychodzi SMS z samym linkiem, żeby nie szukać go w skrzynce.

### SYSTEM W TLE

24 godziny przed wizytą: mail „Jutro o [godzina] — przypomnienie o wizycie” i SMS z terminem oraz datą graniczną bezpłatnego odwołania. 2 godziny przed wizytą online: SMS z linkiem do rozmowy. Po wizycie: propozycja kolejnego terminu u tej samej osoby.

Najbliższy możliwy termin to 2 godziny od teraz. To świadomy wybór na rzecz osób w kryzysie — ktoś, kto rano czuje, że musi porozmawiać, może umówić się jeszcze tego samego dnia. Kosztem jest to, że specjalista dowiaduje się o wizycie na ostatnią chwilę.

Kalendarz jest otwarty na 30 dni w przód. Dalej pacjent nie zarezerwuje, bo specjaliści wystawiają terminy najwyżej na 7 dni i grafik za miesiąc byłby deklaracją, a nie realną dostępnością.

Wybrany termin jest trzymany 10 minut. Krócej — nie zdąży ktoś, kto płaci przelewem albo szuka karty. Dłużej — jedna niedokończona rezerwacja blokuje godzinę na pół dnia i inni widzą ją jako zajęta.

Konto nie jest wymagane. Wymuszanie rejestracji przed pierwszą wizytą odsiewa część osób na progu, a fundacji nie daje nic, czego nie da adres e-mail.

Wizyt niskopłatnych przysługuje 10. Liczba pozostałych jest pokazana PRZED płatnością, a nie po niej — pacjentka ma się dowiedzieć o wyczerpanym limicie w chwili wyboru usługi, nie po zaksięgowaniu przelewu.

Kto zaczął leczenie niskopłatnie, kontynuuje niskopłatnie, dopóki ma limit — u tego samego albo innego specjalisty. Chodzi o to, żeby dofinansowanie szło na cały proces terapeutyczny, a nie na pojedyncze spotkania.

Po wyczerpaniu 10 wizyt nikt nie traci dostępu do pomocy. Można umawiać się dalej w cenie pełnej albo poprosić koordynatora o zwiększenie puli — bez zaświadczeń, wystarczy krótka informacja o sytuacji, a odpowiedź przychodzi zwykle tego samego dnia.

Psycholog prowadzący przypisuje się automatycznie po pierwszej odbytej wizycie. Nikt nie ustawia tego ręcznie, a pacjentka może umówić się u kogoś innego — pojedyncza wizyta u innej osoby nie zmienia przypisania, zmianę prowadzącego potwierdza koordynator.

SMS nie zawiera ani nazwy usługi, ani słowa o zdrowiu, a nadawcą jest „Niepodzielni”, nie nazwa poradni. Wiadomość wyświetla się na zablokowanym ekranie, często przy innych ludziach.

Nie ma pakietów ani serii wizyt. Każda wizyta to osobna rezerwacja i osobna płatność, więc odwołanie jednej sesji nie wymaga rozliczania pakietu i nie powstaje pytanie o zwrot za niewykorzystaną część.

## Odwołanie wizyty przez pacjenta — w oknie 24 godzin i po jego upływie PACJENT

Coś wypadło i pacjentka chce oddać termin — a fundacja chce, żeby dowiedziała się o skutkach, zanim kliknie, a nie po fakcie.

### 1 Otwiera swoje wizyty

Przy każdej nadchodzącej wizycie widzi termin, kwotę, formę i link albo adres. Nad przyciskami stoi jedno z dwóch zdań: albo „Możesz jeszcze bezpłatnie zmienić lub odwołać — masz na to czas do [data], godz. [godzina]”, albo „Minął czas na bezpłatną zmianę”. To zdanie decyduje o wszystkim, co dalej.

### 2 Rozgałęzienie A: zostało więcej niż 24 godziny — otwiera okno odwołania

Przyciski „Przełóż termin” i „Odwołaj wizytę” są widoczne. Po kliknięciu odwołania okno mówi wprost: do wizyty zostało tyle a tyle godzin, czyli więcej niż 24, więc wraca cała kwota. Widać zapłaconą kwotę, kwotę zwrotu i zdanie, że termin natychmiast zwalnia się dla innych.

### 3 Rozgałęzienie A: podaje powód i potwierdza

Powód jest nieobowiązkowy — do wyboru: nie podaję powodu, choroba, kolizja z obowiązkami, nie potrzebuję już wizyty. Pod listą stoi wyjaśnienie, kto to zobaczy. Po kliknięciu „Odwołaj wizytę” wizyta znika z listy nadchodzących.

#### SYSTEM W TLE

Zwrot 100% kwoty trafia na listę zwrotów do wykonania u koordynatora — pieniądze wracają na tę samą kartę, zwykle w 3–5 dni roboczych. Termin natychmiast wraca do puli wolnych i widzą go inni pacjenci. Ta godzina nie wchodzi do rozliczenia specjalisty. Powód idzie do zbiorczych statystyk fundacji, a specjalista widzi go tylko przy swojej wizycie.

### 4 Rozgałęzienie B: zostało mniej niż 24 godziny — przyciski znikają

Przyciski „Przełóż” i „Odwołaj” nie są wyszarzone — ich po prostu nie ma na ekranie. Zamiast nich pacjentka widzi wyjaśnienie, że wizyta jest płatna niezależnie od obecności, i jeden przycisk: „Napisz do specjalisty”. Wyszarzony przycisk kusi, żeby go klikać i szukać sposobu obejścia, a potem generuje zgłoszenia „nie działa mi”.

#### SYSTEM W TLE

System nic nie wysyła i niczego nie zwraca. Godzina zostaje w rozliczeniu specjalisty.

### 5 Rozgałęzienie B: prosi o wyjątek u człowieka

Napisanie do specjalisty jest jedyną drogą i tak ma być. Na ekranie stoi zdanie: decyzję o wyjątku podejmuje osoba, nie system. Specjalista może potraktować taką sytuację jak odwołanie z pełnym zwrotem — ma to jako osobne pole przy oznaczaniu nieobecności.

#### SYSTEM W TLE

Nic nie dzieje się automatycznie. Jeśli specjalista zdecyduje o wyjątku, zwrot trafia na listę zwrotów do wykonania u koordynatora.

## 6 Rozgałęzienie B: pacjentka po prostu nie przychodzi

Jeśli nie napisze i nie pojawi się na wizycie, specjalista zgłasza nieobecność w swoim panelu. Nieobecność zapisuje się w historii pacjentki i widzi ją koordynator.

### SYSTEM W TLE

Brak zwrotu. Godzina wchodzi do rozliczenia specjalisty tak samo jak odbyta wizyta. Termin nie wraca do puli, bo już minął.

## 7 Zwolniony termin idzie na listę rezerwową

Godzina zwolniona późnym odwołaniem zwykle przepada — nikt jej już nie znajdzie, a specjalista i tak dostaje wynagrodzenie. Dlatego system proponuje ją kolejnym osobom z listy rezerwowej, dopóki ktoś nie przyjmie.

### SYSTEM W TLE

Propozycja idzie mailem i SMS-em jednocześnie. Jeśli termin uda się obsadzić ponownie, pierwsza pacjentka — ta, która odwołała po czasie — dostaje kredyt do wykorzystania, mimo że jej wizyta była płatna.

Granica to 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty. Dokładna data i godzina jest wypisana w trzech miejscach: w potwierdzeniu rezerwacji, w przypomnieniu dzień wcześniej i na karcie wizyty w panelu — nikt nie musi jej liczyć sam.

Powyżej 24 godzin zwrot wynosi 100%, poniżej — 0%. Nie ma progów pośrednich ani opłat częściowych, bo każdy dodatkowy próg to kolejne pytanie do koordynatora i kolejne zdanie w regulaminie, którego nikt nie przeczyta.

Wizyta odwołana późno jest płatna, bo specjalista zablokował ten czas wyłącznie dla jednej osoby i nie mógł przyjąć nikogo innego. Bez tej zasady polityka odwołań przestaje być wiarygodna dla specjalistów.

Po upływie 24 godzin przyciski odwołania i zmiany znikają z ekranu, a nie są wyszarzone. Wyszarzony przycisk zaprasza do klikania i szukania obejścia; brak przycisku z wyjaśnieniem obok zamyka temat.

Wyjątki istnieją, ale podejmuje je człowiek. System nie ma reguły „choroba zwalnia z opłaty”, bo takiej reguły nie da się sprawdzić, a próba jej egzekwowania zamieniłaby koordynatora w kontrolera zwolnień.

Fundacja wykonuje zwroty ręcznie w panelu płatności — system tylko pokazuje, komu i ile się należy. Dlatego nigdzie nie pisze „zwrot wykonany”, tylko „zwrot do wykonania”; automatyczne zwroty to najdroższy kawałek integracji płatniczej, a przy kilkudziesięciu zwrotach miesięcznie kliknięcie jest tańsze niż jego utrzymanie.

Jeśli późno odwołany termin uda się odsprzedać komuś z listy rezerwowej, pierwsza osoba dostaje kredyt. Fundacja nie zarabia dwa razy na tej samej godzinie.

## Przełożenie terminu przez pacjenta **PACJENT**

Pacjentka chce zostać u tej samej osoby, ale w innej godzinie — i nie chce płacić drugi raz ani przechodzić przez odwołanie i nową rezerwację.

### 1 Klika „Przełóż termin”

Przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy do wizyty zostało więcej niż 24 godziny i limit zmian nie został wyczerpany. Stoi obok czerwonego przycisku odwołania, ale pierwszy — przełożenie jest lepsze dla obu stron niż odwołanie.

### 2 Wybiera nowy dzień i godzinę

Okno pokazuje 7 najbliższych dni z liczbą wolnych godzin przy każdym; dni bez terminów są nieaktywne. Po wybraniu dnia widzi wolne godziny tej samej osoby. Na górze stoi wyjaśnienie: zmienia tylko godzinę, specjalista, cena i forma zostają bez zmian.

#### SYSTEM W TLE

Nic jeszcze się nie zmienia. Stary termin nadal jest zajęty.

### 3 Potwierdza nowy termin

Przycisk jest nieaktywny, dopóki nie wybierze godziny. Na dole okna stoi licznik: „Zmiana 1 z 2 dozwolonych dla tej rezerwacji” — pacjentka wie, ile jej zostało, zanim kliknie.

#### SYSTEM W TLE

Stary termin natychmiast wraca do puli wolnych i mogą go zarezerwować inni. Płatność przechodzi na nowy termin — nie pobieramy jej drugi raz i nie ma zwrotu. Pacjentka dostaje zaktualizowane potwierdzenie z nową datą, a przypomnienia — dzień przed i dwie godziny przed — przeliczają się na nowy termin.

### 4 Przy trzeciej próbie przycisk jest nieaktywny

Jeśli tę wizytę przekładano już 2 razy, przycisk „Przełóż termin” przestaje działać, a nad nim pojawia się wyjaśnienie: „Tę wizytę przekładano już 2 razy z dozwolonych 2. Kolejna zmiana wymaga kontaktu ze specjalistą”. Odwołanie nadal jest możliwe.

#### SYSTEM W TLE

Nic nie idzie automatycznie. Trzecią zmianę ustala się bezpośrednio ze specjalistą.

### 5 Chce zmienić osobę, nie godzinę

Zmiana specjalisty nie jest możliwa w tym oknie. Na ekranie stoi wprost: jeśli chcesz kogoś innego, odwołaj wizytę i zarezerwuj nową. Odwołanie w oknie 24 godzin jest bezpłatne, więc nic na tym nie traci.

#### SYSTEM W TLE

Odwołanie uruchamia zwykłą ścieżkę: zwrot 100% do wykonania u koordynatora, termin wraca do puli.



Jedną rezerwację można przełożyć 2 razy. Trzecia zmiana zwykle znaczy, że ten termin w ogóle nie pasuje do życia pacjentki — wtedy lepsza jest rozmowa ze specjalistą niż kolejne przesuwanie godziny, które blokuje jego kalendarz.

Zmiana terminu podlega tej samej granicy 24 godzin co odwołanie. Gdyby przełożenie było możliwe później, wystarczyłoby przełożyć wizytę na odległy termin i odwołać ją następnego dnia — czyli obejść zasadę odpłatności.

Przełożenie zmienia tylko godzinę. Specjalista, cena i forma zostają, bo zmiana osoby to inna decyzja i wymaga świadomego wyboru, a nie kliknięcia w oknie zmiany godziny.

Płatność przechodzi na nowy termin i nie ma zwrotu ani ponownego pobrania. Zwrot i nowa płatność przy każdej zmianie godziny oznaczałyby kilka dni oczekiwania na pieniądze i sztucznie napompowaną listę zwrotów do wykonania.

Licznik zmian widać przed kliknięciem, nie po. Informacja „zmiana 1 z 2” w chwili wyboru terminu jest użyteczna; ta sama informacja po wyczerpaniu limitu jest już tylko odmową.

## Umówienie kolejnej wizyty przez specjalistę w gabinecie

PSYCHOLOG

Specjalistka chce ustalić kolejne spotkanie na koniec sesji, nie rozmawiając w gabinecie o pieniądzach i nie przyjmując płatności.

### 1 Otwiera umawianie

Może kliknąć „Umów pacjenta” u góry listy swoich wizyt albo „Kolejny termin” przy wierszu osoby, która właśnie u niej jest — wtedy nazwisko wpisuje się samo. Okno da się otworzyć w trakcie sesji albo później, tego samego dnia.

### 2 Wpisuje pacjenta i rodzaj wizyty

Podaje imię, nazwisko i adres e-mail — na ten adres pójdzie link do płatności. Wybiera rodzaj wizyty z listy, przy każdej pozycji widzi cenę i czas trwania. Przy pacjencie kontynuującym proces niskopłatny wybiera konsultację niskopłatną za 55 zł.

### 3 Wybiera termin z grafiku albo wpisuje go ręcznie

Domyślnie wybiera z własnego grafiku — 7 najbliższych dni z liczbą wolnych godzin przy każdym. Może też przełączyć się na wpisanie daty i godziny ręcznie, jeśli chce dać komuś termin poza wystawionymi godzinami. Przy terminie spoza grafiku pojawia się ostrzeżenie: nikt inny go nie zarezerwuje, ale też nikt nie przypomni, że ma wtedy pracować.

#### SYSTEM W TLE

Termin wpisany ręcznie trafia do jej kalendarza i do rozliczenia tak samo jak każdy inny.

### 4 Wysyła link do płatności

Klika „Zarezerwuj i wyślij link do płatności”. Rozmowa o pieniądzach kończy się w tym momencie — reszta dzieje się między pacjentem a systemem, poza gabinetem.

#### SYSTEM W TLE

Pacjent dostaje mail „Do opłacenia: wizyta [data] o [godzina]” z nazwiskiem specjalistki, terminem, kwotą i linkiem do zapłaty. W mailu stoi data, do której termin jest dla niego trzymany — 2 dni od wysłania. Po otwarciu linku ma 10 minut na dokończenie płatności. Jeśli nie zapłaci w ciągu 2 dni, termin wraca do puli wolnych i specjalistka widzi to na liście swoich wizyt. Po zapłaceniu idzie zwykle potwierdzenie mailem i SMS-em, tak samo jak przy rezerwacji własnej.

### 5 Wariant: prosi o zwolnienie z opłaty

Zamiast wysyłać link, może zaznaczyć „Poproś koordynatora o zwolnienie z opłaty” i wpisać krótkie uzasadnienie. Uzasadnienie ma dotyczyć wyłącznie sytuacji finansowej — pod polem stoi wprost, żeby nie wpisywać tam informacji o zdrowiu. Przycisk zmienia się na „Wyślij wniosek i zablokuj termin”.

#### SYSTEM W TLE

Mail do koordynatora z nazwiskiem pacjenta, terminem, kwotą, uzasadnieniem i linkiem do decyzji. Termin jest zablokowany do czasu decyzji — nikt inny go nie zarezerwuje. Pacjent w tym momencie nie dostaje żadnego linku do płatności ani informacji, że wniosek został złożony.

## 6 Widzi, co się stało z terminem

Nieopłacone wizyty są widoczne na liście rezerwacji ze statusem „czeka na płatność”. Jeśli termin wrócił do puli, specjalistka nie musi tego nigdzie sprawdzać — po prostu znika z jej kalendarza jako zajęty.

### SYSTEM W TLE

Koordinator widzi te same rezerwacje w swoim zestawieniu, w kaflu „Czeka na płatność”.

Specjalista nigdy nie pobiera pieniędzy. Wpisuje dane i wybiera termin, a płatność odbywa się między pacjentem a systemem — dzięki temu rozmowa o pieniądzach nie wchodzi do gabinetu i nie obciąża relacji terapeutycznej.

Na opłacenie terminu umówionego przez specjalistę są 2 dni, a nie 10 minut jak przy rezerwacji własnej. Sytuacja jest inna: pacjent nie siedzi przy komputerze z kartą, tylko wychodzi z gabinetu i dostaje link mailem. Dwa dni to weekend plus dzień roboczy — mieści się w tym osoba, która płaci przelewem po wypłacie.

Po otwarciu linku do płatności termin jest trzymany jeszcze 10 minut na samo dokończenie transakcji, tak jak przy każdej innej rezerwacji.

Specjalista wystawia terminy najwyżej na 7 dni w przód. Fundacja chce mieć pewność, że grafik odzwierciedla realną dostępność, a nie deklaracje sprzed miesiąca.

Termin spoza grafiku jest dozwolony i nie wymaga niczyjej zgody. Gabinet nie działa według kalendarza — osoba w kryzysie potrzebuje jutra, a nie najbliższego wolnego terminu za dwa tygodnie. Specjalista bierze wtedy godzinę spoza wystawionych i sam odpowiada za to, że będzie wolny.

Uzasadnienie wniosku o zwolnienie z opłaty jest wyłącznie finansowe. Koordinator podejmuje decyzję o pieniądzach i nie potrzebuje do tego żadnej informacji o zdrowiu pacjenta.

Termin objęty wnioskiem o zwolnienie jest zablokowany do czasu decyzji. Bez tego pacjent mógłby dostać zgodę na wizytę, której godziny już nie ma.

## Odwołanie wizyty przez specjalistę i co dzieje się z listą rezerwową PSYCHOLOG

Specjalistka nie może przyjąć w umówionej godzinie i chce, żeby pacjent dowiedział się o tym natychmiast, dostał pieniądze z powrotem i miał czym zastąpić utracony termin.

### 1 Klika „Odwołaj” przy konkretnej wizycie

Robi to z listy swoich nadchodzących wizyt. Przy wizytach, do których zostało mniej niż 24 godziny, w kolumnie statusu widnieje dopisek „pacjent nie może już odwołać” — specjalistka wie, że po drugiej stronie nie ma już wyjścia awaryjnego.

### 2 Widzi skutki, zanim potwierdzi

Okno mówi wprost dwie rzeczy: pacjent dostanie pełny zwrot niezależnie od tego, ile zostało do wizyty, a ta godzina nie wejdzie do jej rozliczenia. Nie ma tu żadnego progu czasowego — zasada jest ta sama godzinę przed wizytą i tydzień przed.

### 3 Podaje powód i decyduje o propozycjach terminów

Wybiera powód z listy: choroba, sytuacja losowa, nakładający się obowiązek zawodowy albo inny. Powód zobaczy koordynator — jest to napisane obok pola. Domyślnie zaznaczone jest pole „Zaproponuj pacjentowi trzy najbliższe wolne terminy z mojego kalendarza”; może je odznaczyć.

### 4 Potwierdza odwołanie

Klika „Odwołaj i powiadom pacjenta”. Wizyta znika z jej listy nadchodzących.

#### SYSTEM W TLE

Pacjent dostaje jednocześnie mail „Wizyta [data] niestety się nie odbędzie” — z kwotą zwrotu, informacją o 3 dniach roboczych, linkiem do wyboru nowego terminu i zdaniem, że może odpisać, jeśli woli, żeby fundacja zaproponowała termin sama — oraz SMS z tą samą informacją w skrócie i linkiem. Zwrot 100% trafia na listę zwrotów do wykonania u koordynatora. Godzina wypada z rozliczenia specjalistki. Odwołanie dolicza się do jej licznika odwołań z ostatnich 30 dni.

### 5 Koordynator dostaje sygnał, jeśli odwołań jest dużo

Po przekroczeniu 10 odwołań w ciągu 30 dni u koordynatora zapala się alert. Nie jest to kara ani wpis do akt — dziesięć odwołań w miesiącu prawie zawsze znaczy, że po drugiej stronie dzieje się coś, czego nie widać w grafiku: choroba, wypalenie, zbyt gęsto ułożony tydzień.

#### SYSTEM W TLE

Alert widzi wyłącznie koordynator. Specjalista nie dostaje żadnej wiadomości ani ostrzeżenia.

## 6 Zwolniony termin trafia na listę rezerwową

Godzina, którą specjalistka zwolniła, nie wraca po prostu do kalendarza i nie czeka, aż ktoś ją przypadkiem znajdzie. System sam proponuje ją osobom, które zapisały się do kolejki u tej osoby i na ten rodzaj wizyty, po kolei, dopóki ktoś nie przyjmie.

### SYSTEM W TLE

Propozycja idzie mailem i SMS-em jednocześnie. Pierwsza osoba w kolejce ma 4 godziny na odpowiedź, przy czym zegar zatrzymuje się między 21:00 a 8:00. Po tym czasie propozycja przechodzi do następnej osoby automatycznie, bez udziału koordynatora.

## 7 Koordynator obserwuje odzysk i może przyspieszyć

Na swoim ekranie widzi, ile osób czeka w kolejce, które terminy się zwolniły, ile godzin przed wizytą je odwołano i co z nich wyszło: obsadzony ponownie, propozycja wysłana albo przepadł. Widzi też, ile pieniędzy odzyskano i ile mimo wszystko przepadło. Przy trwającej propozycji może kliknąć „Przekaż dalej”, gdy wie, że pierwsza osoba jest nieosiągalna.

### SYSTEM W TLE

Kliknięcie „Przekaż dalej” przenosi propozycję do następnej osoby od razu, zamiast czekać do końca czterech godzin.

## 8 Kolejka jest ułożona według czasu oczekiwania

Pierwsza jest osoba, która czeka najdłużej. Przy nazwiskach widać, ile razy ktoś dostał propozycję i jej nie przyjął — po dwóch nieprzyjętych propozycjach warto zapytać, czy ta osoba nadal chce czekać, zamiast wysłać jej kolejne. Widać też, kto zgadza się na termin w ciągu 24 godzin, bo tylko takim osobom ma sens proponować godzinę zwolnioną na jutro.

Gdy odwołuje specjalista, pacjent zawsze dostaje pełny zwrot — nawet godzinę przed wizytą. Ta asymetria wobec zasady 24 godzin jest celowa: pacjent nie ma wpływu na to, że specjalista zachorował, a bez tej różnicy polityka odwołań przestałaby być wiarygodna dla pacjentów.

Godzina odwołana przez specjalistę nie wchodzi do jego rozliczenia. Gdy to pacjent odwołuje późno albo nie przychodzi, godzina jest płatna i wchodzi. Bez tej różnicy zasada przestałaby być wiarygodna dla którejś ze stron.

Alert u koordynatora zapala się po przekroczeniu 10 odwołań w oknie 30 dni. Okno jest tu równie ważne jak próg — licznik od początku współpracy przekroczyłby dziesiątkę u każdej aktywnej osoby w ciągu roku i sygnał przestałby cokolwiek znaczyć. Chodzi o to, co dzieje się teraz.

Pierwsza osoba w kolejce ma 4 godziny na przyjęcie zwolnionego terminu. Doba marnuje termin zwolniony na jutro — zanim propozycja wygaśnie, wizyta już minie. Kwadrans karze za to, że ktoś jest akurat w pracy albo na sesji. Cztery godziny mieszczą się w dniu roboczym i pozwalają przejść przez trzy osoby w kolejce.

Zegar czterech godzin zatrzymuje się na noc, między 21:00 a 8:00. Propozycja wysłana o 22:00 nie może wygasnąć, zanim ktokolwiek się obudzi — inaczej fundacja karałaby ludzi za sen.

Powód odwołania widzi koordynator, nie pacjent. Pacjent dostaje informację, że wizyta się nie odbędzie i że pieniądze wracają; szczegóły sytuacji specjalisty do niego nie należą.

Zwrot po odwołaniu przez specjalistę też jest wykonywany ręcznie przez koordynatora. W mailu i SMS-ie pacjent dostaje termin „3 dni robocze”, bo tyle realnie zajmuje ta operacja razem z księgowaniem po stronie banku.

## Zamknięcie miesiąca: od podsumowania u specjalisty przez fakturę do akceptacji koordynatora

### PSYCHOLOG

Specjalistka chce dostać wypłatę za miniony miesiąc, a fundacja chce mieć pewność, że zapłaciła dokładnie tyle, ile się należy — ani mniej, ani więcej.

#### 1 Oznacza, co się wydarzyło na wizytach

W zakładce „Do oznaczenia” ma wizyty z ostatnich dni czekające na rozstrzygnięcie: odbyła się albo pacjent nie przyszedł. Nieobecność musi zgłosić sama — to ona decyduje, że pacjent nie dostaje zwrotu. Przy zgłaszaniu nieobecności może zaznaczyć „odpuść tym razem”, jeśli pacjent uprzedził ją inną drogą.

##### SYSTEM W TLE

Po 48 godzinach system sam uzna nieoznaczoną wizytę za odbytą i wliczy ją do rozliczenia. Zgłoszona nieobecność zapisuje się w historii pacjenta i jest widoczna dla koordynatora; pacjent nie dostaje zwrotu, a godzina wchodzi do rozliczenia specjalistki. „Odpuszczenie” zamienia to na odwołanie z pełnym zwrotem, który trafia na listę zwrotów do wykonania.

#### 2 Sprawdza podsumowanie okresu

Na ekranie rozliczeń widzi cztery liczby: kwotę do wypłaty, liczbę godzin spędzonych w gabinecie, liczbę godzin opłaconych mimo braku pacjenta oraz datę najbliższej wypłaty — 10 dnia miesiąca. Poniżej ma dwie listy: wizyty odbyte i osobno godziny opłacone mimo braku pacjenta, czyli późne odwołania i nieobecności.

##### SYSTEM W TLE

Kwota przy każdej pozycji to jej wynagrodzenie — dokładnie tyle, ile trafi na przelew. Fundacja pobiera 20% prowizji od wizyt pełnopłatnych, ale ta liczba nie pojawia się nigdzie na ekranie specjalisty.

#### 3 Sprawdza, czy liczby się zgadzają

Obok stoi krótka tabelka, kiedy godzina jest płatna: wizyta się odbyła — tak; pacjent odwołał późno — tak; pacjent nie przyszedł — tak; pacjent odwołał w terminie — nie; specjalistka odwołała — nie. Jeśli coś się nie zgadza, ma napisać do koordynatora PRZED wystawieniem faktury.

#### 4 Wysyła fakturę

Klika „Prześlij fakturę”. Okno pokazuje liczbę rozliczanych wizyt, okres, termin przesłania i podpowiedzianą kwotę do wystawienia. Wpisuje własny numer faktury i załącza plik PDF — bez pliku przycisk wysyłki nie działa.

##### SYSTEM W TLE

Po wysłaniu specjalistka dostaje potwierdzenie przyjęcia faktury na swój adres. Faktura pojawia się u koordynatora ze statusem „oczekuje” i wchodzi do kolejki do sprawdzenia.

#### 5 Koordynator otwiera fakturę i porównuje kwoty

Na liście faktur przy każdej pozycji widzi kwotę z faktury, wyliczenie systemu i różnicę między nimi. Jeśli różnicy nie ma, wiersz jest oznaczony jako zgodny i nie wymaga niczego więcej. Cztery kafle u góry mówią, ile faktur czeka, ile już zaakceptowano, ile jest do poprawy i przy ilu jest rozjazd z systemem.

## 6 Wariant zgodny: koordynator akceptuje

Otwiera fakturę, widzi zielone potwierdzenie, że kwota odpowiada rozliczeniu, i klika „Akceptuj do wypłaty”. To cała czynność.

### SYSTEM W TLE

Przelew wychodzi w najbliższej paczce, do 10 dnia miesiąca, na konto z profilu specjalistki. Potwierdzenie księgowania idzie do niej mailem.

## 7 Wariant z różnicą: koordynator prosi o korektę

Przy fakturze niższej niż rozliczenie system podpowiada najczęstszą przyczynę: pominięte godziny opłacone mimo nieobecności pacjenta. Przy fakturze wyższej podpowiada, żeby sprawdzić wizyty umówione telefonicznie albo poza grafikiem. Koordynator klika „Poproś o korektę” i wpisuje konkretnie, czego brakuje — samo „proszę o korektę” bez wskazania pozycji oznacza kolejną wymianę maili i tydzień opóźnienia.

### SYSTEM W TLE

Specjalistka dostaje mail „Faktura [numer] — prośba o korektę” z treścią wpisaną przez koordynatora, wyliczeniem systemu, kwotą z jej faktury i linkiem do przesłania poprawionego dokumentu. Faktura zmienia status na „do poprawy” i widać to od razu na jej ekranie rozliczeń, w wyróżnionej ramce. Wypłata przesuwa się na najbliższą paczkę po akceptacji.

Faktura idzie do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, przelew wychodzi do 10 dnia miesiąca. Jedna data zamiast dwóch osobnych terminów jest łatwiejsza do zapamiętania i nie wymaga tłumaczenia przy każdym nowym specjaliście.

Specjalista nie widzi prowizji fundacji ani kwoty, którą zapłacił pacjent. Z jego perspektywy stawka to po prostu jego stawka, a rozbieżność na kwotę pacjenta i potrącenie nie daje mu żadnej decyzji do podjęcia — zamienia tylko ekran wypłaty w przypomnienie o marży. Pełne rozliczenie widzi koordynator.

Fundacja pobiera 20% od wizyt pełnopłatnych. Wizyty niskopłatne i asystent zdrowienia są bez prowizji — od nich fundacja dopłaca, a nie pobiera.

System podpowiada kwotę, ale nie wystawia faktury za specjalistę. Specjaliści rozliczają się na różnych zasadach — działalność, umowa-zlecenie, ryczałt — i dokument musi wychodzić z ich własnej księgowości.

Bez załączonego pliku faktury nie da się jej wysłać. Fundacja potrzebuje dokumentu z księgowości specjalisty, a nie samej deklaracji kwoty.

Koordynator sprawdza każdą fakturę, nie akceptuje automatycznie. Kwota z faktury bywa NIŻSZA od rozliczenia systemu, bo specjalista liczy z własnego kalendarza i pomija godziny opłacone mimo nieobecności pacjenta. Automatyczna akceptacja oznaczałaby, że fundacja płaci mniej, niż powinna — ten krok chroni przede wszystkim specjalistę.

Status nazywa się „do poprawy”, nie „odrzucona”. Odrzucenie brzmi jak zarzut, a w dziewięciu przypadkach na dziesięć chodzi o pomyłkę w arytmetyce — i o człowieka, z którym fundacja chce dalej pracować.

Po 48 godzinach nieoznaczona wizyta liczy się jako odbyta, ale nieobecność trzeba zgłosić samodzielnie. Domyślne założenie idzie na korzyść pacjenta: brak reakcji nie może skutkować utratą jego pieniędzy.

## Zgłoszenie pierwszego kontaktu i kwalifikacja przez koordynatora **KOORDYNATOR**

Osoba, która pierwszy raz prosi o pomoc, ma dostać jedną konkretną propozycję zamiast listy 111 nazwisk i wyboru między nurtami, o których nic nie wie.

### 1 Osoba wypełnia krótką ankietę

Sześć pytań, wszystkie z zamkniętą listą odpowiedzi, żadnego pola opisowego. Pyta o obszar wsparcia (najwyżej dwa z listy dwunastu, np. lęk, depresja, trauma, żałoba, wypalenie zawodowe), o wcześniejsze doświadczenie terapii, o formę spotkania i miasto, o pilność, o to, czy potrzebuje wizyty dofinansowanej, oraz o kanał kontaktu. Nie ma pytania „opisz swój problem”, nie ma pytań o diagnozy, leki ani hospitalizacje.

#### SYSTEM W TLE

Zgłoszenie dostaje numer i trafia do kolejki koordynatora. Nic nie idzie automatycznie do żadnego specjalisty.

### 2 Koordynator widzi kolejkę

Zgłoszenia są ułożone według deklarowanej pilności powiększonej o czas czekania. Cztery liczby u góry mówią: ile czeka na kwalifikację, ile czeka dłużej niż 24 godziny, ile osób zaznaczyło „pilne” i ile wynosi mediana oczekiwania. Można zawęzić listę do samych pilnych albo do czekających dłużej niż dobę.

#### SYSTEM W TLE

Nic nie wysyła. Licznik „dłużej niż 24 godziny” jest miarą tego, czy fundacja dotrzymuje własnej obietnicy odpowiedzi.

### 3 Otwiera zgłoszenie i widzi dopasowania

W jednym miejscu ma wszystkie odpowiedzi z ankiety oraz trzy propozycje specjalistów wybrane spośród całego zespołu. Przy każdej propozycji stoi uzasadnienie: wspólne obszary pomocy, miasto, jeśli się zgadza, i data pierwszego wolnego terminu. Jeśli ktoś jest wolny dopiero za ponad tydzień, ma to wypisane przy nazwisku.

#### SYSTEM W TLE

Nic nie wysyła. Jeśli osoba zostawiła telefon, numer jest zasłonięty do momentu kliknięcia „Pokaż” — odsłonięcie zapisuje się w logu dostępu, bo ekran kwalifikacji bywa otwarty w biurze, przy którym przechodzą inni.

### 4 Wybiera specjalistę, rodzaj wizyty i jeden termin

Żadna propozycja nie jest zaznaczona z góry — koordynator musi kliknąć. Rodzaj wizyty startuje od tego, co osoba zaznaczyła w ankiecie: niskopłatna, jeśli prosiła o dofinansowanie. Potem wybiera jedną godzinę spośród czterech na dzień, z trzech najbliższych dni tej osoby.

#### SYSTEM W TLE

Jeśli koordynator zmieni niskopłatną na pełnopłatną wbrew ankiecie, pojawia się ostrzeżenie z konkretną ceną i uwagą, że propozycja z niezapowiedzianą ceną kończy się zwykle brakiem odpowiedzi.

### 5 Wysyła propozycję terminu

Przed wysłaniem widzi dokładnie to, co zobaczy osoba zgłaszająca: nazwisko, datę, godzinę, rodzaj wizyty i cenę. Jedna propozycja, nie lista.

#### SYSTEM W TLE

Osoba dostaje propozycję z terminem i linkiem do opłacenia. Termin jest zablokowany na 2 dni — po tym czasie wraca do puli wolnych, a zgłoszenie wraca do kolejki kwalifikacji. Zgłoszenie znika z listy koordynatora i zamienia się w rezerwację; odpowiedzi z ankiety nie wędrują do kartoteki pacjenta.



## 6 Wariant: nie ma do kogo skierować

Jeśli nikt w zespole nie deklaruje tych obszarów, zamiast trzech propozycji koordynator widzi wyjaśnienie: to sytuacja do decyzji człowieka, nie do filtra. Trzeba dopytać o formę, zaproponować grupę wsparcia albo skierować poza fundację.

### SYSTEM W TLE

Nic nie idzie automatycznie.

## 7 Wariant: nikt nie przyjmuje w tym mieście

Gdy osoba prosi o spotkanie stacjonarne w mieście, w którym nikt z zespołu nie przyjmuje, nad propozycjami pojawia się ostrzeżenie. Propozycje są wtedy z innych miast i przed wysłaniem trzeba zapytać, czy wizyta online jest do przyjęcia — dojazd do innego miasta zwykle nie jest.

## 8 Wariant: dwie odpowiedzi to za mało

Koordynator klika „Poproś o rozmowę” zamiast wysłać propozycję. Rozmowa telefoniczna jest tańsza niż trzecie pytanie w ankiecie.

### SYSTEM W TLE

Zgłoszenie wraca do kolejki z adnotacją, że poproszono o rozmowę — nie znika i nie gubi się.

Ankieta pyta o sześć rzeczy i nie ma pola opisowego. Odpowiedzi o zdrowiu psychicznym są danymi szczególnej kategorii — każde dodatkowe pole trzeba zabezpieczyć, przechować i po czasie usunąć. Powód nie jest jednak wyłącznie prawny: osoba, która pierwszy raz prosi o pomoc, opowiada swoją historię terapii, a nie formularzowi na stronie, a formularz pytający o wszystko zamyka się częściej, niż wysyła.

Odpowiedzi celowo nie mają formy „byłam / byłem”. Rodzaj gramatyczny wymusza deklarację płci już w pierwszym kontakcie z fundacją.

Fundacja deklaruje odpowiedź w ciągu 24 godzin. To zobowiązanie organizacyjne, nie blokada w systemie — nic się po tym czasie nie zamyka, ale licznik przeterminowanych zgłoszeń jest widoczny na ekranie koordynatora przez cały czas.

Kolejność ustala pilność razem z czasem czekania, nie jedno z nich. Sama deklaracja premiuje osoby, które potrafią głośno poprosić — a przy pierwszym kontakcie to właśnie najbardziej zmęczeni zaznaczają „bez pośpiechu”. Sam czas czekania spycha realnie pilne zgłoszenia na koniec dnia. W praktyce zgłoszenie „bez pośpiechu” wyprzedza świeże „pilne” po 48 godzinach w kolejce.

Forma spotkania jest twardym filtrem. Osoba, która napisała „stacjonarnie”, ma powód, a propozycja spotkania online byłaby odpowiedzią na inne pytanie.

Specjalista bez wolnego terminu w ciągu tygodnia spada pod gorzej dopasowanych. Idealne dopasowanie z pierwszym wolnym terminem za trzy tygodnie nie jest propozycją, którą można dziś wysłać osobie w kryzysie.

Żadna propozycja nie jest zaznaczona domyślnie. Podpowiedź systemu zostawałaby niezmieniona w większości przypadków, a wtedy kwalifikacja przestałaby być decyzją koordynatora i stałaby się automatem z ludzkim podpisem.

Osoba dostaje jedną propozycję, a nie listę do wyboru. Cały sens tego ekranu polega na przeniesieniu czytania biogramów z osoby proszącej o pomoc na koordynatora — kosztem jest doba zwłoki, którą ten ekran mierzy i pokazuje.

Termin z propozycji jest zablokowany na 2 dni, tak samo jak przy umawianiu przez specjalistę. Po tym czasie wraca do puli, a zgłoszenie wraca do kolejki — nikt nie wypada z systemu przez to, że nie odpisał.

# Co widzi i robi pacjent

Osoba szukająca pomocy — od pierwszego wejścia na stronę, przez wybór terminu i zapłatę, po zarządzanie swoimi wizytami, zapisami na grupy i kontaktem ze specjalistą.

## Strona startowa

Zdjęcie na całą szerokość z hasłem i dwoma przyciskami: „Wspieraj” i „Umów się”. Zaraz pod nim wyróżniona ramka z najbliższym wolnym terminem w całej fundacji — data, godzina i nazwisko osoby, która go ma. Niżej cztery rodzaje konsultacji, każdy z ceną i czasem trwania. Na końcu krótkie wyjaśnienie, że to makietą, a nie działający system, i że wszystkie rezerwacje oraz kwoty są zmyślone.

- Kliknąć „Umów się” i przejść do wyszukiwarki terminów
- Kliknąć najbliższy wolny termin i wejść od razu na profil tej osoby
- Wybrać rodzaj konsultacji i zobaczyć tylko tych specjalistów, którzy ją prowadzą
- Przełączyć się na widok psychologa albo koordynatora — wyłącznie po to, żeby obejrzeć makietę

Najbliższy wolny termin stoi nad cennikiem, a nie pod nim. Osoba, która trafia na tę stronę, najczęściej pyta „kiedy najwcześniej”, a nie „ile to kosztuje” — odpowiedź powinna paść, zanim zacznie czytać.

## Wyszukiwarka wolnych terminów

Wszyscy specjaliści w jednej liście, ułożeni od tego, kto przyjmie najwcześniej. Na każdej karcie widać nazwisko, rolę, kilka zdań o osobie, obszary pomocy, cenę, formę pracy (online albo stacjonarnie z miastem), datę najbliższego terminu oraz do pięciu konkretnych godzin do kliknięcia. Nad listą jest pole wyszukiwania i filtry, a pod nią liczba znalezionych osób. Zalogowana pacjentka widzi dodatkowo pasek z informacją, kto ją prowadzi.

- Wpisać nazwisko, obszar pomocy albo nurt pracy
- Zawęzić listę do jednego rodzaju konsultacji
- Wybrać wizyty online, stacjonarne albo oba rodzaje
- Włączyć „Termin w ciągu 48 h”
- Włączyć „Tylko mój psycholog”
- Wyczyścić wszystkie filtry jednym przyciskiem
- Kliknąć godzinę na karcie i przejść prosto do rezerwacji tego terminu
- Wejść na pełny profil specjalisty

Konkretne godziny są wypisane wprost na karcie, więc nie trzeba wchodzić w profil, żeby sprawdzić, czy ktoś ma cokolwiek wolnego. Psycholog prowadzący idzie na początek listy, ale jej nie ogranicza — pacjentka może umówić się u kogokolwiek. Gdy filtr wyklucza prowadzącego albo nie ma on wolnych godzin, pasek mówi to wprost, zamiast obiecywać coś, czego lista nie pokazuje.

## Profil specjalisty

Duża karta ze zdjęciem, nazwiskiem, tytułem, specjalizacją, oceną w gwiazdkach, językami i nurtami pracy. Trzy zakładki: O mnie, Obszary pomocy, Podejście terapeutyczne. Pod nimi siedem dni do kliknięcia, przy każdym liczba wolnych godzin, a obok lista godzin z wybranego dnia. Z boku wybór rodzaju konsultacji z ceną, czasem trwania i przypomnieniem, że odwołanie jest bezpłatne do 24 godzin przed wizytą, a termin trzymamy przez 10 minut na czas płatności. Na dole cztery kroki „Jak zarezerwować wizytę” i opinie.

- Przełączać zakładki z opisem specjalisty
- Wybrać dzień i zobaczyć godziny z tego dnia
- Zmienić rodzaj konsultacji — cena przelicza się od razu, strona się nie przeładowuje
- Kliknąć godzinę i przejść do rezerwacji
- Wrócić do listy specjalistów
- Spróbować dodać opinię — dostępne dopiero po odbytej wizycie

Jeśli pacjentkę prowadzi ktoś inny, widzi tu zdanie, że ta wizyta jest jednorazowa i nie zmienia przypisania. Profil to ostatni ekran przed płatnością, więc ostatni moment, żeby to powiedzieć.

## Rezerwacja — dane i płatność

Na górze trzy kroki: termin jest już odhaczony, zostają dane i płatność. Formularz z imieniem, mailem, telefonem, pytaniem, czy była już u nas, i miejscem na kilka zdań przed wizytą. Osobna sekcja z pytaniem, czy założyć konto. Sekcja zgód, w tym wyróżniona zgoda na zasady odwoływania. Z boku podsumowanie: kto, kiedy, ile trwa, ile kosztuje, licznik odliczający czas blokady terminu i informacja o sposobach płatności. Przy konsultacji niskopłatnej widać też, która to wizyta z puli.

- Poprawić imię, mail i telefon
- Napisać kilka zdań o tym, z czym przychodzi
- Zaznaczyć założenie konta i ustawić hasło albo zostać przy rezerwacji jako gość
- Zaznaczyć zgody
- Wrócić i zmienić termin
- Zapłacić i zarezerwować wizytę

Zgoda na zasady odwoływania nie mówi tylko „24 godziny”, ale podaje konkretną datę i godzinę, do której odwołanie jest bezpłatne. Przeliczanie w głowie jest źródłem nieporozumień, wypisana data nie jest. Stan puli wizyt niskopłatnych też widać tutaj, przed zapłatą — a nie dopiero po zaksięgowaniu przelewu.

## Potwierdzenie rezerwacji

Zielony znaczek, napis „Wizyta zarezerwowana”, numer rezerwacji i informacja, na jaki adres poszło potwierdzenie. Karta z nazwiskiem specjalisty, terminem, rodzajem wizyty, formą i zapłaconą kwotą. Od razu, bez czekania na przypomnienie, widać link do spotkania albo adres gabinetu z piętnem i numerem domofonu. Niżej oś „Co się teraz wydarzy”: teraz, 24 godziny przed, 2 godziny przed, po wizycie. Na końcu trzy propozycje kolejnego terminu — ten sam dzień i godzina w kolejnych tygodniach.

- Skopiować link do spotkania
- Pobrać wpis do kalendarza
- Przejść do zarządzania swoją rezerwacją
- Umówić od razu kolejną wizytę u tej samej osoby

Nie ma pakietów ani serii wizyt. System proponuje kolejny termin, ale każda wizyta jest osobną rezerwacją i osobną płatnością. Dzięki temu odwołanie jednej sesji nie wymaga rozliczania pakietu i nie powstaje pytanie o zwrot za niewykorzystaną część.

## Warsztaty i grupy wsparcia — lista

Karty spotkań ułożone od najbliższego. Na każdej: data w dużym kwadracie, nazwa, rodzaj spotkania, opis, kto prowadzi, kiedy i gdzie się odbywa, cena oraz opis rytmu, na przykład „8 spotkań, co tydzień”. Z boku pasek pokazujący, ile miejsc jest już zajętych, a przy komplecie — ile osób czeka w kolejce.

- Zawęzić listę do jednego rodzaju spotkań
- Wejść w konkretne spotkanie
- Przejść wprost do zapisu albo do listy rezerwowej

Gdy miejsca się kończą, zapisy nie zamykają się — przechodzą na listę rezerwową. W grupach wsparcia rezygnacje są częste, a każde puste krzesło to miejsce, którego nikt już nie zajmie.

## Spotkanie grupowe

Nagłówek z datą, nazwą, rodzajem, opisem, czasem trwania, miejscem i osobami prowadzącymi. Pod spodem harmonogram wszystkich spotkań cyklu, ponumerowany, z wyblakłymi terminami tych, które już się odbyły. Z boku liczba wolnych miejsc z paskiem, liczba spotkań, koszt i przycisk zapisu. Osoba, która jest już zapisana, widzi zamiast tego swój status — ma miejsce albo czeka na liście, z podaną pozycją.

- Zapisać się na spotkanie — otwiera się okno z danymi, harmonogramem, kosztem i zgodą na stały skład grupy
- Dopisać się na listę rezerwową, gdy miejsc już nie ma
- Zrezygnować z udziału
- Wejść na profil osoby prowadzącej
- Wrócić do listy spotkań

Rezygnacja ze spotkania grupowego jest zawsze bezpłatna, także z warsztatu płatnego — inaczej niż przy wizytach indywidualnych. Zwolnione miejsce natychmiast trafia do pierwszej osoby z listy rezerwowej, więc nikt na tym nie traci.

## Potwierdzenie zapisu na spotkanie

Dwa różne ekrany zależnie od sytuacji: „Masz miejsce” albo „Jesteś na liście rezerwowej” z podaną pozycją w kolejce. Poniżej nazwa spotkania, data pierwszego spotkania, liczba spotkań, miejsce i koszt. Osoba z potwierdzonym miejscem dostaje od razu link albo adres. Przy cyklu widać wszystkie terminy naraz.

- Skopiować link do spotkania
- Pobrać wszystkie terminy cyklu do kalendarza
- Przejść do swoich zapisów
- Wejść na profil osoby prowadzącej

Osoba na liście rezerwowej nie płaci nic. Zapłaci dopiero wtedy, gdy miejsce naprawdę się zwolni i je potwierdzi. Gdyby płaciła z góry, po każdym warsztacie fundacja miałaby kolejkę zwrotów dla osób, które nigdy do grupy nie weszły.

## Logowanie

Pole na adres mailowy, pole na hasło i przycisk logowania. Pod nimi odsyłacz „Nie pamiętam hasła” i informacja, że konto zakłada się samo przy pierwszej rezerwacji. Na dole lista kont przygotowanych po to, żeby dało się obejrzeć makietę z każdej strony.

- Zalogować się mailem i hasłem
- Poprosić o link do ustawienia nowego hasła
- Kliknąć konto z listy, żeby formularz wypełnił się sam
- Przejść do umawiania wizyty, jeśli konta jeszcze nie ma

W gotowym systemie prawie nikt tego ekranu nie zobaczy. Pacjentka wchodzi do swojego panelu linkiem z maila, bez hasła. Logowanie jest dla osób, które wracają po miesiącach i nie mają już tamtej wiadomości, oraz dla specjalistów i koordynatorów, gdzie hasło jest konieczne.

## Pulpit pacjenta

Powitanie po imieniu i cztery liczby na wierzchu: za ile jest najbliższa wizyta, ile wizyt czeka, ile już się odbyło i ile wizyt niskopłatnych zostało z puli — z paskiem pokazującym zużycie. Poniżej ramka z psychologiem prowadzącym. Dalej pełna karta najbliższej wizyty z linkiem albo adresem i datą, do której zmiana jest jeszcze bezpłatna. Na dole grupy, na które pacjentka jest zapisana, i zestawienie „Zasady, które Cię dotyczą” z pięcioma konkretnymi liczbami.

- Umówić nową wizytę
- Napisać wiadomość do prowadzącego
- Umówić kolejną wizytę u prowadzącego
- Skopiować link do spotkania albo pobrać wpis do kalendarza
- Przejść do zarządzania wizytami
- Zobaczyć swoje grupy albo przejrzeć otwarte
- Sprawdzić w jednym miejscu wszystkie zasady, które jej dotyczą

Pulpit odpowiada na jedno pytanie: co mnie czeka i czy muszę coś zrobić. Nie ma tu żadnych sum wydanych na wizyty ani historii finansowej — pacjentka widzi cenę pojedynczej wizyty przed zapłatą i nie ponad to.

## Moje wizyty

Dwie zakładki: Nadchodzące i Historia. Na karcie nadchodzącej wizyty widać, kto ją prowadzi, jaki to rodzaj konsultacji, ile trwa i w jakiej formie, dużą datę z godziną, za ile to będzie, numer rezerwacji i kwotę. Poniżej link do spotkania albo adres gabinetu. Na samym dole zielona ramka „Możesz jeszcze bezpłatnie zmienić lub odwołać” z konkretną datą i godziną albo pomarańczowa ramka „Minął czas na bezpłatną zmianę”. W Historii jest skrócona lista wizyt ze statusem i kwotą.

- Przełączyć się między nadchodzącymi a historią
- Skopiować link do spotkania albo dołączyć do niego
- Przełożyć termin — otwiera się okno z dniami i wolnymi godzinami oraz licznikiem, która to zmiana z dwóch dozwolonych
- Odwołać wizytę — otwiera się okno z kwotą zwrotu, wyjaśnieniem zasady i polem na powód
- Napisać do specjalisty, gdy na samodzielną zmianę jest już za późno
- Umówić nową wizytę

To najważniejszy ekran w całym obszarze. Gdy do wizyty zostało mniej niż 24 godziny, przyciski „Przełóż termin” i „Odwołaj wizytę” znikają z ekranu. Nie są wyszarzone — znikają, a na ich miejscu pojawia się wyjaśnienie i przycisk napisania do specjalisty. Wyszarzony przycisk kusi, żeby go klikać i szukać obejścia, a potem generuje telefony „u mnie nie działa”. Decyzję o wyjątku podejmuje człowiek, nie system.

## Grupy i warsztaty w koncie

Lista spotkań, na które pacjentka jest zapisana. Przy każdym rodzaju spotkania, status — „Masz miejsce” albo „Lista rezerwowa” z pozycją w kolejce — nazwa, rytm spotkań, cena oraz data i miejsce najbliższego spotkania. Pod listą wyjaśnienie, że rezygnacja i zgłoszenie nieobecności działają najpóźniej 2 godziny przed spotkaniem, czyli inaczej niż przy wizytach indywidualnych.

- Wejść w szczegóły spotkania
- Zgłosić nieobecność na najbliższym spotkaniu
- Zrezygnować z udziału w całym cyklu
- Napisać do prowadzącego, gdy do spotkania zostało mniej niż 2 godziny

Grupy są oddzielone od wizyt indywidualnych, bo rządzą się inną logiką: to cykl w stałym składzie, a nie pojedynczy termin, i rezygnacja jest zawsze bezpłatna, tylko z krótszym oknem.

## Wiadomości

Po lewej lista rozmów, przy każdej tytuł, kontekst — numer wizyty albo nazwa grupy — początek ostatniej wiadomości i licznik nowych. Po prawej otwarta rozmowa: wiadomości ułożone w czasie, podpisane imieniem i informacją, ile godzin albo dni temu przysły. Pod nią pole do napisania odpowiedzi.

- Otworzyć wybraną rozmowę
- Napisać i wysłać wiadomość — odbiorca dostaje powiadomienie mailem

Każda rozmowa ma przy sobie kontekst: numer wizyty albo nazwę grupy. Bez tego po trzech tygodniach nikt nie wie, czego dotyczyła, a moduł zamienia się w drugą skrzynkę mailową, z której nikt nie korzysta. To nie jest kanał kryzysowy — wiadomości czytamy w godzinach pracy, a numery kryzysowe są w stopce każdej strony.

piątek, 7 sierpnia 2026, 12:09

## Moje dane

Imię, adres mailowy z wyjaśnieniem, po co go używamy, telefon i strefa czasowa. Niżej sposób płatności: cztery ostatnie cyfry karty i data ważności, z uwagą, że reszty danych karty w ogóle nie przechowujemy. Dalej trzy zgody, z których jedna jest zablokowana. Na końcu sekcja o prawie do pobrania wszystkich swoich danych i do usunięcia konta.

- Poprawić imię, mail, telefon i strefę czasową, a potem zapisać zmiany
- Zmienić kartę płatniczą
- Włączyć albo wyłączyć informacje o warsztatach i przypomnienia SMS
- Pobrać wszystko, co fundacja o niej przechowuje
- Poprosić o usunięcie konta

Nie ma tu notatek z sesji ani dokumentacji terapeutycznej — to dane szczególnej kategorii i wymagają osobnej decyzji fundacji: kto ma do nich dostęp, jak długo są przechowywane i czy pacjent widzi je u siebie. Zgoda na przetwarzanie danych o zdrowiu jest zablokowana, bo bez niej nie da się prowadzić wizyt; odznaczenie jej oznaczałoby przerwanie leczenia, a to nie powinno dziać się jednym kliknięciem.

## Zasady obowiązujące w tym obszarze

**Wizytę można odwołać albo przełożyć bezpłatnie najpóźniej 24 godziny przed jej rozpoczęciem. Wtedy pacjentka dostaje z powrotem 100% kwoty.**

Specjalista rezerwuje tę godzinę wyłącznie dla jednej osoby i nie przyjmuje w niej nikogo innego. Doba to tyle, ile realnie trzeba, żeby ktoś inny zdążył zająć zwolniony termin — przy krótszym oknie godzina i tak przepada.

**Gdy do wizyty zostało mniej niż 24 godziny, jest ona płatna niezależnie od obecności i nie ma zwrotu. Specjalista dostaje za tę godzinę wynagrodzenie.**

Zablokował ten czas i nie mógł przyjąć nikogo innego. Praca została wykonana po jego stronie, nawet jeśli spotkanie się nie odbyło.

**Po przekroczeniu 24 godzin nie działa też zmiana terminu, nie tylko odwołanie. Przyciski znikają z ekranu, zostaje wyjaśnienie i kontakt do specjalisty.**

Gdyby zostawić furtkę na przełożenie, nikt by nie odwoływał — wszyscy by przekładali. Godzina i tak przepada, a zasada 24 godzin przestałaby cokolwiek znaczyć. Tak samo rozwiązują to inne systemy rezerwacji wizyt: późne przełożenie liczy się jak późne odwołanie.

**Termin odwołany później niż 24 godziny przed wizytą i tak wraca do puli. Jeśli ktoś inny go wykupi, pierwsza pacjentka dostaje równowartość jako kredyt na kolejną wizytę.**

Lepiej, żeby godzina się odbyła, niż stała pusta. Specjalista ma ją opłaconą tak czy inaczej, a różnicę pokrywa fundacja — to jest właśnie ta sytuacja, w której fundacja dokłada, żeby pacjentka nie została z niczym.

**Jedną rezerwację można przełożyć 2 razy. Trzecia zmiana wymaga kontaktu ze specjalistą.**

Dwie zmiany to normalne życie: choroba dziecka, nagły dyżur. Trzecia prawie zawsze znaczy, że ten termin w ogóle nie pasuje — i wtedy krótka rozmowa ze specjalistą daje więcej niż kolejne przesunięcie w kalendarzu.

**Najbliższy termin, jaki da się zarezerwować, zaczyna się 2 godziny od teraz.**

Osoba, która rano czuje, że musi z kimś porozmawiać, może umówić się jeszcze tego samego dnia. Kosztem jest to, że specjalista dowiaduje się o wizycie na ostatnią chwilę — to świadomy wybór fundacji na rzecz osób w kryzysie.

**Pacjentka widzi terminy na 30 dni w przód, ale specjalista wystawia konkretne godziny najwyżej 7 dni do przodu.**

Grafik ma pokazywać realną dostępność z najbliższego tygodnia, a nie deklarację sprzed miesiąca. Termin sprzed miesiąca bardzo często kończy się odwołaniem po stronie specjalisty, a to najgorsza możliwa rzecz dla kogoś, kto już się na tę wizytę nastawił.

**Wybrany termin jest zablokowany dla jednej osoby przez 10 minut na czas płatności. Po tym czasie wraca do puli.**

Bez blokady dwie osoby płacą za tę samą godzinę i jedna dostaje zwrot zamiast wizyty. 10 minut wystarcza na zapłatę kartą albo BLIK-iem, a jednocześnie nie trzyma godziny zajętej przez kogoś, kto się rozmyślił i zamknął kartę.

**Każdej osobie przysługuje 10 wizyt niskopłatnych. Koordynator może ten limit podnieść pojedynczej pacjentce.**

Fundacja dopłaca różnicę między ceną niskopłatną a rynkową z dotacji, a ta pula jest skończona. Po wyczerpaniu limitu nikt nie traci dostępu do pomocy — przechodzi na wizyty pełnopłatne albo pisze do koordynatora z prośbą o zwiększenie puli.

**Liczymy wizyty, a nie minuty: „3 z 10 wizyt”, nie „pozostało 1 godzina 40 minut”.**

„3 z 10 wizyt” każdy rozumie od razu i sam policzy, ile mu jeszcze zostało. Licznik w minutach generuje telefony do koordynatora z pytaniem, na ile spotkań to wystarczy.



**Kto zaczął leczenie w trybie niskopłatnym, rezerwuje kolejne wizyty też jako niskopłatne — u tego samego albo u innego specjalisty — dopóki ma pulę.**

Dofinansowanie ma iść na cały proces terapeutyczny, a nie na pojedyncze, przypadkowe spotkania. Pacjentka może wybrać wizytę pełnopłatną i wtedy jej pula zostaje nienaruszona.

**Jeden specjalista może wystawić najwyżej 4 terminy niskopłatne tygodniowo.**

To ograniczenie działa przy układaniu grafiku, a nie przy rezerwacji. Pacjentka nigdy nie powinna zobaczyć wolnego terminu, po który dostanie odmowę przy płatności — czyli w najgorszym możliwym momencie, po podjęciu decyzji i wyjęciu karty.

**Między wizytami jest zawsze 10 minut przerwy.**

Specjalista potrzebuje chwili na zanotowanie czegoś i złapanie oddechu, a pacjentka nie mija się w drzwiach z osobą, która wyszła przed nią.

**Z grupy albo warsztatu można zrezygnować najpóźniej 2 godziny przed spotkaniem — zawsze bezpłatnie, także przy warsztacie płatnym. Wpłata wraca w całości.**

Przez te 2 godziny miejsce da się jeszcze przekazać komuś z listy rezerwowej, więc nikt na rezygnacji nie traci. Później prowadzący ma już ustalony skład grupy i liczy na obecność wszystkich.

**Zapisy na spotkanie grupowe zamykają się 2 godziny przed jego rozpoczęciem.**

Prowadzący musi wiedzieć, ile osób przyjdzie i przygotować spotkanie pod ten skład. Osoba dopisana kwadrans przed startem wchodzi do grupy, która zaczęła się już bez niej.

**Gdy w pełnej grupie zwolni się miejsce, pierwsza osoba z listy rezerwowej dostaje maila i ma 24 godziny na potwierdzenie. Potem propozycja idzie do następnej.**

Doba mieści w sobie dzień pracy i noc, więc realnie da się zdążyć. Dłuższe czekanie blokowałoby miejsce, na które czeka ktoś kolejny, a grupa i tak odbywa się w wyznaczonym terminie.

**Osoba na liście rezerwowej nie płaci nic z góry. Płaci dopiero po tym, jak miejsce się zwolni i ona je potwierdzi.**

Gdyby lista płaciła z góry, po każdym warsztacie fundacja miałaby kolejkę zwrotów dla osób, które nigdy do grupy nie weszły. Nie trzymamy pieniędzy ludzi, którzy czekają w kolejce.

**W istniejącej rezerwacji można zmienić godzinę, ale nie osobę specjalisty. Żeby trafić do kogoś innego, trzeba odwołać wizytę i zarezerwować nową.**

Cena, forma pracy i dostępność są związane z konkretną osobą. „Podmiana” zostawiłaby płatność, która nie pasuje ani do starej, ani do nowej wizyty, i zwykle wymagałaby dopłaty albo zwrotu w tle — czego nikt by nie zrozumiał.

**Do zarezerwowania wizyty nie trzeba zakładać konta. Konto powstaje samo po opłaceniu, a dostęp przychodzi linkiem w mailu.**

Osoba w kryzysie nie powinna wymyślać hasła, zanim umówi wizytę. Kto chce, może ustawić hasło od razu przy rezerwacji albo później.

**Link do spotkania online albo adres gabinetu pacjentka dostaje od razu po rezerwacji — w potwierdzeniu na ekranie, w mailu i na karcie wizyty w swoim panelu.**

Trzymanie linku do przypomnienia na 2 godziny przed wizytą oznacza, że ktoś, kto ma słabszy zasięg albo problem ze skrzynką, dowiaduje się o tym w ostatniej chwili. Informacja dostępna w trzech miejscach nie zginie.

**Przed każdą wizytą przychodzą dwa przypomnienia: mailem 24 godziny przed i drugie 2 godziny przed, z linkiem do spotkania.**

Pierwsze trafia dokładnie w moment, w którym zmiana terminu jest jeszcze bezpłatna — pacjentka ma wtedy realny wybór. Drugie oszczędza szukania linku w skrzynce tuż przed spotkaniem.

**Zwrot pieniędzy wraca na tę samą kartę, zwykle w 3–5 dni roboczych, i zleca go człowiek z fundacji.**

Fundacja klika zwrot ręcznie w panelu płatności, bo automatyczne zwroty to najdroższy i najbardziej awaryjny kawałek obsługi płatności. Dlatego nigdzie nie piszemy „zwrot wykonany”, tylko „zwrot do wykonania” — nie obiecujemy czegoś, czego system sam nie robi.

**Każda pacjentka ma jednego psychologa prowadzącego. Przypisuje się on sam przy pierwszej odbytej wizycie. Wizyta u kogoś innego jest dozwolona i nie zmienia przypisania; stałą zmianę potwierdza koordynator.**

Przy pomocy w kryzysie liczy się najbliższy wolny termin, a nie ciągłość opieki za wszelką cenę — dlatego nie blokujemy rezerwacji u innych osób. Mówimy jednak wprost, że taka wizyta jest jednorazowa, żeby nikt nie odkrył po fakcie, że właśnie zmienił terapeutę.

**Pacjentka nie widzi w swoim panelu żadnych sum wydanych na wizyty ani historii finansowej. Widzi cenę pojedynczej wizyty przed zapłatą.**

Fundacja pomocowa nie powinna przypominać komuś, ile łącznie zapłacił za to, że szukał pomocy. Do podjęcia decyzji o konkretnej wizycie wystarczy cena tej wizyty.

# Co widzi i robi psycholog — panel specjalisty

*Z tego obszaru korzysta osoba prowadząca konsultacje w fundacji — psycholog, psychoterapeutka albo asystent zdrowienia — żeby ustawić swoje godziny przyjęć, prowadzić własne wizyty, oznaczać, co się na nich wydarzyło, i pilnować, żeby wynagrodzenie na koniec miesiąca się zgadzało.*

## Stałe obramowanie panelu (menu i nagłówek)

Po lewej stronie, na każdym ekranie tak samo, widać spis miejsc podzielony na trzy grupy: Praca (pulpit, wizyty, grupy i warsztaty, wiadomości), Kalendarz (moje kalendarze, dostępność) i Pieniądze (rozliczenia, dokumenty i wypłaty). U góry jest logo fundacji, imię i nazwisko zalogowanej osoby, jej tytuł zawodowy i przycisk wylogowania. Specjalista nie ma tu niczego, co dotyczy innych osób — nie widzi grafiku całego zespołu ani finansów fundacji.

- Przejść do jednego z ośmiu miejsc panelu
- Wrócić na stronę fundacji, klikając logo
- Wylogować się

Podział na trzy grupy jest celowy. Specjalista wchodzi do panelu z jednym z trzech pytań: co mam dzisiaj, kiedy przyjmuję, ile zarobiłam. Jedna długa lista ośmiu pozycji zmuszałaby do przeczytania wszystkich za każdym razem.

## Pulpit — pierwszy ekran po zalogowaniu

Na górze cztery liczby: ile wizyt jest dzisiaj i ile z nich jeszcze przed specjalistą, ile wolnych godzin zostało w najbliższym tygodniu, jaki procent wystawionych godzin jest już zajęty i ile wyniosło wynagrodzenie z ostatnich 30 dni. Pod tym lista dzisiejszych wizyt: godzina, długość, imię i nazwisko pacjenta, rodzaj wizyty, forma spotkania i kwota. Po prawej stronie kolumna „Wymaga uwagi” z konkretnymi sprawami do załatwienia oraz słupki na siedem najbliższych dni — ciemny słupek to wizyty umówione, jasny to godziny wystawione, których nikt jeszcze nie zajął.

- Dołączyć do spotkania online — przycisk pojawia się na godzinę przed wizytą
- Otworzyć szczegóły nadchodzącej wizyty
- Oznaczyć wizytę, która już się odbyła
- Przejść do pełnej listy wizyt
- Przejść do ustawiania godzin przyjęć

Dwie rzeczy ustawione świadomie. Po pierwsze, pulpit pokazuje tylko imię pacjenta, rodzaj wizyty i formę — żadnych notatek ani historii, bo ten ekran bywa otwarty na laptopie, gdy w gabinecie siedzi kolejna osoba. Po drugie, gdy dzisiaj nie ma żadnej wizyty, ekran pokazuje najbliższy dzień, w którym coś jest, zamiast pustego miejsca — pusty pulpit niczego nie mówi o tym, jak system działa.

## Wizyty — lista w trzech zakładkach

Zakładka „Nadchodzące” to tabela wizyt na najbliższe trzy tygodnie: termin, pacjent, rodzaj wizyty, sposób spotkania, wynagrodzenie i status. Przy wizytach, do których zostało mniej niż 24 godziny, pod statusem dopisane jest wprost „pacjent nie może już odwołać”. Zakładka „Do oznaczenia” — z liczbą przy nazwie — zbiera wizyty z ostatnich dni, przy których trzeba powiedzieć, co się wydarzyło. Zakładka „Historia” pokazuje zamknięte wizyty razem z informacją, czy weszły do wypłaty, czy są poza nią.

- Przełączać się między trzema zakładkami
- Skopiować link do spotkania online jednym kliknięciem
- Otworzyć szczegóły wizyty
- Umówić pacjenta na kolejny termin
- Odwołać wizytę po swojej stronie
- Oznaczyć „odbyła się”
- Oznaczyć „nie przyszedł”
- Pobrać listę wizyt do arkusza

Zdanie „pacjent nie może już odwołać” jest tam po coś. Gdy pacjent zadzwoni z prośbą o przełożenie na dzień przed wizytą, specjalista od razu wie, że system tego nie robi i decyzja należy do niego — zamiast odsyłać pacjenta do ekranu, który mu tego nie pozwoli.

## Okno: szczegóły wizyty

Rodzaj wizyty i jej długość, forma, numer rezerwacji i kwota wynagrodzenia. Przy wizycie online — link do spotkania; przy stacjonarnej — nazwa gabinetu i numer pokoju. Na dole krótka informacja o pacjencie w rodzaju „to trzecia wizyta tej osoby w fundacji, poprzednie odbyły się bez zakłóceń”.

- Skopiować link do spotkania
- Wpisać własny link — na przykład do swojego stałego pokoju
- Zmienić gabinet na inny z listy fundacji
- Zapisać zmianę, która od razu idzie do pacjenta mailem i SMS-em

Miejsce spotkania da się zmienić przy konkretnej wizycie, a nie raz na zawsze w profilu, bo ta sama osoba potrafi przyjmować w dwóch miejscach w różne dni, a czasem używa własnego pokoju online. Przycisk nazywa się „Zapisz i powiadom pacjenta”, a nie samo „Zapisz” — inaczej powstałyby dwie wersje prawdy: adres w systemie i adres w mailu sprzed tygodnia.

## Okno: odwołuję wizytę

Na górze żółte ostrzeżenie: pacjent dostanie pełny zwrot niezależnie od tego, ile zostało do wizyty, a ta godzina nie wejdzie do rozliczenia specjalisty. Pod spodem wybór powodu: choroba, sytuacja losowa, nakładający się obowiązek zawodowy albo inny powód — z dopiskiem, że powód zobaczy koordynator. Na dole zaznaczone już pole: „Zaproponuj pacjentowi trzy najbliższe wolne terminy z mojego kalendarza”.

- Wybrać powód odwołania
- Zdecydować, czy pacjent dostanie propozycje trzech terminów
- Potwierdzić odwołanie
- Wrócić bez odwoływania

Propozycja trzech terminów jest zaznaczona z góry. Odwołanie bez propozycji zostawia pacjenta samego ze zwrotem na koncie i koniecznością szukania nowego terminu od zera — a to najczęstszy moment, w którym ludzie rezygnują z pomocy.

## Okno: pacjent się nie pojawił

Czerwony blok opisujący skutki dla pacjenta: wizyta zostaje płatna, bez zwrotu, a nieobecność zapisze się w jego historii i zobaczy ją koordynator. Pod spodem trzy zdania wprost: godzina wchodzi do rozliczenia specjalisty — tak; zwrot dla pacjenta — brak; termin wraca do puli — nie, bo już minął. Na dole pole do zaznaczenia: „Odpuść tym razem — potraktuj jako odwołanie z pełnym zwrotem”.

- Zapisać nieobecność
- Zaznaczyć odpuszczenie i potraktować sprawę jak zwykłe odwołanie z pełnym zwrotem
- Anulować i nic nie zapisywać

Furtka „odpuść tym razem” istnieje dlatego, że życie dzieje się poza systemem — pacjent uprzedził SMS-em, zadzwonił albo napisał do specjalisty prywatnie. Bez tej możliwości specjalista musiałby albo skrzywdzić pacjenta, albo dzwonić do koordynatora po każdej takiej sytuacji.

## Okno: umów pacjenta na kolejny termin

Pola na imię, nazwisko i adres e-mail pacjenta — wypełnione z góry, gdy specjalista umawia kogoś, kto właśnie był na wizycie. Niżej wybór rodzaju wizyty z ceną i długością, a pod nim siedem najbliższych dni z liczbą wolnych godzin przy każdym i lista godzin do wyboru. Jest też przełącznik „z grafiku / wpisz ręcznie” oraz pole „Poproś koordynatora o zwolnienie z opłaty”. Na dole wyjaśnienie: pacjent dostanie maila z linkiem do płatności, a termin będzie trzymany 10 minut od otwarcia tego linku.

- Wpisać dane pacjenta
- Wybrać rodzaj wizyty
- Wybrać dzień i godzinę z własnego grafiku
- Wpisać termin spoza grafiku ręcznie
- Poprosić koordynatora o zwolnienie pacjenta z opłaty i dopisać uzasadnienie
- Wysłać — pacjent dostaje maila z linkiem do płatności

Najważniejsza rzecz w tym oknie: psycholog nigdy nie pobiera pieniędzy. Wybiera termin, a płatność idzie mailem — dzięki temu rozmowa o pieniądzach nie wchodzi do gabinetu i nie kończy sesji na wyjmowaniu karty. Przy wniosku o zwolnienie z opłaty jest wprost napisane, żeby nie wpisywać informacji o zdrowiu — koordynatorowi wystarczy powód finansowy.

## Moje kalendarze — co przyjmuję

Lista usług fundacji podzielona na trzy części: te, które specjalista przyjmuje; te, które może włączyć; te, które wymagają zgody fundacji. Przy każdej usłudze widać opis, czas trwania, cenę (albo wybór własnej stawki przy konsultacjach pełnopłatnych), formę pracy oraz podsumowanie godzin przyjęć — na przykład „wt, czw 9:00–13:00, 8 godzin tygodniowo”. Przy usługach zablokowanych zamiast przełącznika jest wyjaśnienie, dlaczego są zablokowane, i przycisk poproszenia o dostęp.

- Włączyć albo wyłączyć usługę
- Wybrać własną stawkę pełnopłatną z czterech kwot ustalonych przez fundację
- Wybrać formę pracy: online, stacjonarnie albo obie
- Poprosić koordynatora o uprawnienie do usługi zablokowanej
- Przejść do ustawiania godzin dla danej usługi

Wyłączenie usługi zatrzymuje tylko nowe rezerwacje — umówione wizyty zostają. Cennik i długość spotkania ustala fundacja, a jedyna cena, o której decyduje specjalista, to stawka pełnopłatna wybrana z widełek. W dzisiejszym systemie „niskopłatne” i „pełnopłatne” to dwa oddzielne konta tej samej osoby; tutaj to jedno konto z dwoma kalendarzami — rozdzielone są godziny, nie tożsamość specjalisty.

## Dostępność — kiedy przyjmuję

Na górze dwie zakładki: godziny ustawia się osobno dla konsultacji pełnopłatnych i osobno dla niskopłatnych. Przy niskopłatnych dodatkowo pasek „Twoja pula na ten tydzień — 3 z 4”. Krok pierwszy to tygodniowy rytm: siedem dni z przełącznikami i zakresami godzin, z licznikiem, ile terminów tygodniowo z tego wychodzi. Krok drugi to siatka siedmiu dni na godziny, w czterech kolorach: godziny z rytmu, dodane ręcznie, wyłączone i zajęte przez pacjenta. Niżej tabela wolnego i urlopów, spis reguł ustawionych przez fundację oraz miejsce na połączenie z prywatnym kalendarzem.

- Przełączać się między usługą pełnopłatną a niskopłatną
- Włączać i wyłączać całe dni tygodnia
- Dodawać, usuwać i zmieniać zakresy godzin
- Kliknąć pojedynczą godzinę, żeby ją wyłączyć albo dołożyć poza rytmem
- Wyczyścić wszystkie poprawki naraz
- Dodać urlop lub inne wolne i zobaczyć, ile wizyt w tym czasie trzeba przełożyć
- Zapisać harmonogram
- Podłączyć prywatny kalendarz Google (poza makietą, do decyzji)

Dwa poziomy zamiast samego klikania po kalendarzu: rytm tygodniowy ustawia się raz na kilka miesięcy i odpowiada za większość terminów, a klikanie po siatce służy do wyjątków w rodzaju „w ten czwartek wyjątkowo o 8:00”. Poprawki na siatce są jednorazowe — dotyczą jednego konkretnego dnia, więc żeby coś zmienić na stałe, trzeba poprawić rytm. Godziny już zajętej przez pacjenta nie da się kliknąć, bo nie da się cofnąć godziny, na którą ktoś przyjdzie.

## Grupy i warsztaty

Na górze cztery liczby: ile spotkań specjalista prowadzi, ilu uczestników ma razem, ile to godzin grupowych i kiedy jest najbliższe spotkanie. Pod tym informacja, że terminy i limity miejsc ustala koordynator. Niżej karty poszczególnych grup: nazwa, rodzaj, stan zapisów (na przykład 8 z 10 miejsc), pasek wypełnienia, data i godzina, miejsce albo „online”, cena od osoby, liczba osób na liście rezerwowej i nazwiska współprowadzących.

- Otworzyć listę uczestników grupy
- Pobrać listę obecności do arkusza
- Zgłosić koordynatorowi chęć poprowadzenia grupy albo warsztatu

Specjalista nie zakłada grup — robi to koordynator, bo trzeba naraz pogodzić kompetencje, terminy i wolne sale. Świadome ograniczenie: specjalista widzi imiona i nazwiska uczestników, bo musi wiedzieć, kto siedzi w sali, ale nie widzi, kto i ile zapłacił — to zostaje między pacjentem a fundacją.

## Okno: uczestnicy grupy

Tabela osób zapisanych: imię i nazwisko, adres e-mail, kiedy się zapisały i status — potwierdzony, obecny, nieobecny albo „rezerwowa” z numerem w kolejce. Pod tabelą informacja, ile osób czeka na miejsce, oraz harmonogram wszystkich spotkań cyklu, w którym minione daty są przygaszone.

- Oznaczyć nieobecność konkretnej osoby
- Napisać wiadomość do całej grupy
- Zamknąć okno

Przy liście rezerwowej napisane jest wprost: jeśli ktoś zrezygnuje, pierwsza osoba z kolejki dostanie miejsce automatycznie i prowadzący nie musi nic robić. Bez tego zdania ludzie szukają przycisku, którego nie ma, albo dzwonią do koordynatora.

## Okno: zgłoszenie do prowadzenia grupy

Na górze wyjaśnienie, że to prośba, a nie rezerwacja — decyduje koordynator, a odpowiedź przychodzi mailem. Pod tym wybór, czego zgłoszenie dotyczy: nowa grupa wsparcia, dołączenie do istniejącej jako współprowadzący albo warsztat jednodniowy. Dalej pole na temat i grupę odbiorców oraz pole na własną dostępność.

- Wybrać rodzaj zgłoszenia
- Opisać temat i dla kogo grupa ma być
- Podać, kiedy może prowadzić
- Wysłać zgłoszenie do koordynatora

Okno nazywa rzecz po imieniu — „to prośba, nie rezerwacja”. Gdyby przycisk nazywał się po prostu „Utwórz grupę”, specjalista czekałby, aż grupa pojawi się na stronie, a koordynator dowiedziałby się o tym w momencie, gdy zapisze się pierwszy pacjent.

## Rozliczenia

Cztery liczby na górze: ile jest do wypłaty i za ile wizyt, ile godzin specjalista przepracował w gabinecie, ile godzin zostało opłaconych mimo braku pacjenta i kiedy wychodzi najbliższa wypłata. Pod tym tabela wizyt z kwotą przy każdej i sumą na dole, a osobno druga tabela: godziny opłacone mimo braku pacjenta, z podaniem, co się wydarzyło. Po prawej stronie ściągawka „kiedy godzina jest płatna”, miejsce na przesłanie faktury z historią wcześniejszych oraz lista wypłat z poprzednich okresów.

- Zmienić okres rozliczeniowy
- Pobrać zestawienie dla własnej księgowości
- Przesłać fakturę za miniony miesiąc
- Zobaczyć status każdej faktury i przeczytać prośbę o poprawę, jeśli jest

Czego tu celowo nie ma: kolumny „pacjent zapłacił” i wiersza z prowizją fundacji. Specjalista widzi swoją stawkę, bo tylko na nią ma wpływ — rozbiecie każdej wizyty na kwotę pacjenta minus potrącenie nie daje mu żadnej decyzji do podjęcia, a zamienia ekran wypłaty w przypomnienie o marży. Godziny opłacone mimo braku pacjenta są w osobnej tabeli, żeby było widać, skąd bierze się różnica między liczbą odbytych spotkań a kwotą do wypłaty.



## Okno: prześlij fakturę

Podsumowanie okresu: ile wizyt jest rozliczanych, jakiego miesiąca dotyczy faktura, do kiedy trzeba ją przesłać i jaka jest kwota do wystawienia. Pod tym wyjaśnienie, skąd ta kwota — to suma stawek za wizyty odbyte plus godziny opłacone mimo nieobecności pacjenta. Niżej pole na numer faktury i miejsce na wgranie pliku PDF, a na końcu trzy kroki opisujące, co dzieje się dalej: koordynator sprawdza kwotę, przelew wychodzi, potwierdzenie przychodzi mailem.

- Wpisać numer faktury
- Załączyć plik PDF
- Wysłać fakturę — przycisk działa dopiero, gdy jest i numer, i plik
- Anulować

System podpowiada kwotę, ale faktury nie wystawia. Specjaliści rozliczają się na różnych zasadach — działalność, umowa zlecenie, ryczałt — więc dokument musi wyjść z ich własnej księgowości. Krok z akceptacją koordynatora chroni specjalistę, bo kwota z faktury bywa niższa od rozliczenia systemu: ludzie liczą z własnego kalendarza i pomijają godziny opłacone mimo nieobecności pacjenta. Dlatego status nazywa się „do poprawy”, a nie „odrzucona” — w dziewięciu przypadkach na dziesięć chodzi o pomyłkę w rachunkach.

## Dokumenty i wypłaty

Umowa o współpracy z datą podpisania, formą współpracy i listą aneksów, oznaczona jako podpisana. Pod tym tabela stawek: ile specjalista dostaje za konsultację pełnopłatną, ile za niskopłatną i ile za spotkanie grupy, z adnotacją, że są to kwoty do wypłaty i nic się z nich nie odejmuje. Niżej numer konta bankowego z oznaczeniem „zweryfikowany” oraz opis, jak wygląda miesiąc rozliczeniowy: zestawienie do 5 dnia, uwagi do 8 dnia, przelew do 10 dnia.

- Pobrać umowę w PDF
- Pobrać aneks
- Zmienić numer konta do wypłat, potwierdzając zmianę linkiem z maila

Umowa leży w panelu, żeby specjalista nie musiał jej szukać w mailach sprzed roku. Numer konta zmienia sam, bo to jego dane, ale zmiana wchodzi w życie dopiero po kliknięciu w link wysłany na jego adres — to zabezpieczenie na wypadek, gdyby ktoś obcy dostał się do jego konta w systemie i podmienił rachunek przed wypłatą.

## Wiadomości

Po lewej lista rozmów: tytuł, przy nim kontekst — numer wizyty albo nazwa grupy — początek ostatniej wiadomości i zielona liczba nowych. Po prawej cała rozmowa ułożona jak czat, z informacją, kto i kiedy pisał, oraz pole do napisania odpowiedzi. Pod rozmową ostrzeżenie, że to nie jest kanał kryzysowy: wiadomości czytamy w godzinach pracy, a przy zagrożeniu życia trzeba reagować telefonicznie.

- Otworzyć wybrany wątek
- Napisać i wysłać wiadomość — odbiorca dostaje powiadomienie mailem

Każdy wątek jest podpięty pod konkretną wizytę albo grupę. Bez tego po trzech tygodniach nie wiadomo, czego rozmowa dotyczyła, a moduł zamienia się w drugą skrzynkę mailową, z której nikt nie korzysta. Ostrzeżenie o kanale kryzysowym widzi specjalista i koordynator, a nie pacjent — to instrukcja dla osoby, która ma zareagować.

**Zasady obowiązujące w tym obszarze**

### **Specjalista wystawia terminy najwyżej na 7 dni do przodu — dalsze dni są w panelu zablokowane.**

Fundacja chce, żeby grafik pokazywał realną dostępność, a nie deklarację sprzed miesiąca. Termin wystawiony na sześć tygodni naprzód najczęściej trzeba potem odwołać, a odwołana wizyta kosztuje pacjenta więcej niż termin, którego nigdy nie było.

### **Jeden specjalista może wystawić 4 terminy niskopłatne tygodniowo. Pula odnawia się w każdy poniedziałek, a godziny pełnopłatne są bez ograniczeń.**

Pula dofinansowania jest skończona, więc fundacja steruje nią w momencie wystawiania godzin, a nie przy rezerwacji. Gdyby blokada działała na końcu, pacjent zobaczyłby wolny termin i dostał odmowę dopiero przy płatności — czyli w najgorszym możliwym momencie, po podjęciu decyzji i wyjęciu karty.

### **Miedzy wizytami system zostawia 10 minut przerwy.**

Ta przerwa to czas na notatkę, toaletę i złapanie oddechu. Bez niej pięć wizyt pod rząd oznacza, że piąty pacjent czeka pod drzwiami dwadzieścia minut, a specjalista pracuje bez chwili przerwy.

### **Najbliższy termin, jaki pacjent może zarezerwować, to 2 godziny od teraz.**

To świadomy wybór na rzecz osób w kryzysie: ktoś, kto rano czuje, że musi porozmawiać, może umówić się jeszcze tego samego dnia. Kosztem jest to, że specjalista dowiaduje się o takiej wizycie na ostatnią chwilę — fundacja przyjęła, że to koszt wart poniesienia.

### **Pacjent widzi kalendarz otwarty na 30 dni w przód.**

Miesiąc wystarcza, żeby zaplanować terapię, a jednocześnie nie zachęca do rezerwowania terminów, o których za dwa miesiące nikt nie będzie pamiętał.

### **Pacjent odwołuje bezpłatnie do 24 godzin przed wizytą. Później wizyta zostaje płatna, pacjent nie dostaje zwrotu, a godzina wchodzi do rozliczenia specjalisty.**

Specjalista zablokował ten czas i nie mógł przyjąć nikogo innego. Doba to tyle, ile realnie potrzeba, żeby ktoś inny zdążył ten termin znaleźć i zarezerwować.

### **Pacjent może przełożyć jedną rezerwację 2 razy i tylko wtedy, gdy do wizyty zostało więcej niż 24 godziny. Po tym czasie zmiany terminu nie ma wcale.**

Gdyby zostawić furtkę na późne przełożenie, nikt nie odwoływałby wizyt — wszyscy by je przekładali. Godzina i tak przepada, a okno 24 godzin przestaje cokolwiek znaczyć. Tak samo rozwiązują to inne systemy rezerwacji wizyt: późne przełożenie liczy się jak późne odwołanie.

### **Gdy wizytę odwołuje specjalista — o dowolnej porze, także na godzinę przed — pacjent dostaje 100% zwrotu, a ta godzina nie wchodzi do rozliczenia specjalisty.**

Ta różnica jest celowa. Skoro pacjent ponosi konsekwencje późnego odwołania, to specjalista też musi je ponosić — inaczej polityka odwołań przestaje być wiarygodna dla którejś ze stron i ludzie zaczynają ją obchodzić.

### **Gdy pacjent nie przychodzi bez uprzedzenia: brak zwrotu, godzina płatna dla specjalisty, a termin nie wraca do puli, bo już minął.**

Nikt nie mógł tej godziny wykorzystać. Specjalista czekał w gabinecie, więc dostaje za nią wynagrodzenie tak samo jak za spotkanie, które się odbyło.

### **Wizytę trzeba oznaczyć w ciągu 48 godzin. Po tym czasie system sam uznaje ją za odbytą — ale nieobecność pacjenta specjalista musi zgłosić osobiście.**

Automat po dwóch dobach pilnuje, żeby rozliczenie nie stanęło, gdy ktoś zapomni kliknąć. Nieobecności system nie zgadnie i nie może jej założyć, bo to właśnie ona odbiera pacjentowi zwrot — taka decyzja musi mieć człowieka po

### **10 odwołań ze strony jednego specjalisty w ciągu 30 dni zapala sygnał u koordynatora.**

To nie jest kara, tylko zaproszenie do rozmowy — dziesięć odwołań w miesiącu prawie zawsze znaczy, że po drugiej stronie dzieje się coś, czego nie widać w grafiku: choroba, wypalenie, zbyt gęsto ułożony tydzień. Licznik obejmuje 30 dni, a nie całą współpracę, bo od początku współpracy każda aktywna osoba przekroczyłaby dziesiątkę w ciągu roku i sygnał przestałby cokolwiek znaczyć.

### **Konsultacja niskopłatna kosztuje pacjenta 55 zł, a pełnopłatna 115, 125, 135 albo 145 zł. Innych kwot w systemie nie ma.**

Cennik ustala fundacja i jest ten sam dla wszystkich. Specjalista wybiera własną stawkę pełnopłatną, ale tylko z tych czterech kwot — dzięki temu pacjent porównujący dwie osoby porównuje doświadczenie i termin, a nie cenę wymyśloną przez kogoś samodzielnie.

### **Fundacja zatrzymuje 20% z wizyty pełnopłatnej i 0% z niskopłatnej, ale ta liczba nie pojawia się nigdzie w panelu specjalisty.**

Specjalista widzi kwotę, którą dostanie, bo tylko na nią ma wpływ. Pokazywanie mu przy każdej wizycie, ile zostało w fundacji, nie daje mu żadnej decyzji do podjęcia. Pełne rozliczenie — wpływ, prowizja, marża — widzi koordynator.

### **Jednemu pacjentowi przysługuje 10 wizyt niskopłatnych; koordynator może ten limit podnieść pojedynczej osobie.**

Fundacja dopłaca do tych wizyt z dotacji, więc pula jest skończona. Po wyczerpaniu limitu pacjent nie traci dostępu do pomocy — przechodzi na wizyty pełnopłatne albo prosi koordynatora o zwiększenie. Liczymy spotkania, a nie minuty, bo „3 z 10 wizyt” każdy rozumie od razu, a „pozostało 1 godzina 40 minut” kończy się telefonem do koordynatora.

### **Wizytę umówioną przez specjalistę pacjent ma 2 dni na opłacenie. Gdy rezerwuje sam na stronie, termin jest trzymany 10 minut.**

To dwie różne sytuacje. Kto rezerwuje sam, siedzi przy komputerze z kartą w ręku — dziesięć minut wystarczy. Kto wychodzi z gabinetu i dostaje link mailem, potrzebuje więcej: dwa dni to weekend plus dzień roboczy, więc mieści się w tym także osoba, która płaci przelewem po wypłacie.

### **Fakturę specjalista przesyła do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Zestawienie do sprawdzenia dostaje do 5 dnia, uwagi zgłasza do 8 dnia, przelew wychodzi do 10 dnia.**

Te trzy daty ustawiają cały miesiąc: jest pięć dni na sprawdzenie liczb i trzy dni na zgłoszenie różnicy, zanim pieniądze wyjdą. Po przelewie poprawki i tak trzeba przenieść na następny okres, więc lepiej zdążyć wcześniej.

### **2 z 4 usług w katalogu — diagnoza ADHD u dorosłych i asystent zdrowienia — wymagają uprawnienia nadanego przez koordynatora. Specjalista nie włączy ich sam.**

Diagnozę prowadzą wyłącznie osoby po odpowiednim szkoleniu, a asystentami zdrowienia zostają osoby z własnym doświadczeniem kryzysu po szkoleniu fundacji. Uprawnienie potwierdza fundacja, więc to ona je nadaje — specjalista może o nie poprosić jednym kliknięciem.

### **Wpisane wolne — na przykład 14 dni urlopu — wyłącza terminy we wszystkich usługach naraz i ma pierwszeństwo zarówno przed tygodniowym rytmem, jak i przed pojedynczymi poprawkami w siatce godzin.**

Urlop jest urlopem niezależnie od tego, czy w tym tygodniu miały wypaść konsultacje pełnopłatne, czy niskopłatne. Jedna reguła, która wygrywa ze wszystkim, oznacza, że nie da się przypadkiem zostawić otwartego terminu w środku wyjazdu. System od razu pokazuje też, ile już umówionych wizyt trzeba w tym czasie przełożyć.

### **Zmiana numeru konta do wypłat wymaga 1 kliknięcia w link wysłany na adres e-mail specjalisty. Do tego czasu przelew idzie na stary rachunek.**

To zabezpieczenie na wypadek, gdyby ktoś obcy dostał się do konta w systemie tuż przed dniem wypłaty. Sam dostęp do panelu nie wystarczy, żeby przekierować pieniądze — trzeba mieć jeszcze skrzynkę e-mail.

**Za poprowadzenie 90-minutowego spotkania grupy specjalista dostaje 180 zł, niezależnie od tego, czy przyszło 4 czy 12 osób.**

Praca prowadzącego jest ta sama bez względu na frekwencję, a ryzyko pustej sali bierze na siebie fundacja, nie specjalista. Gdyby wynagrodzenie zależało od liczby uczestników, prowadzący musiałby zabiegać o zapisy zamiast prowadzić grupę.

# Co widzi i robi koordynator

*Panel koordynacji fundacji: osoba prowadząca zespół i kalendarz widzi tu wszystkie zgłoszenia, wizyty, pieniądze i decyzje, żeby wiedzieć, komu pomóc dzisiaj, kto z zespołu potrzebuje rozmowy i czym rozliczyć się z dotacji.*

## Belka rodzaju wizyt (nad każdym ekranem koordynacji)

Nad wszystkimi ekranami koordynacji stoi pasek na całą szerokość, wielkimi literami, który mówi, jakie wizyty są w tej chwili pokazywane: łącznie, tylko niskopłatne albo tylko pełnopłatne. Domyślnie ustawione jest „łącznie”, czyli wszystko. Gdy koordynatorka zawęzi widok, pasek zmienia kolor i zostaje na ekranie do momentu przełączenia z powrotem.

- przełączyć wszystkie ekrany na widok „łącznie”, „niskopłatne” albo „pełnopłatne”
- wrócić do pełnego widoku jednym kliknięciem w pasku

Sam mały przełącznik w rogu nie wystarczył. Zawężone liczby wyglądają dokładnie tak samo poprawnie jak pełne — nic w tabeli nie sygnalizuje, że połowa danych jest ukryta, i to najgorszy rodzaj pomyłki, bo nie da się jej zauważyć. Dlatego jest pasek, którego trudno nie widzieć. Zawężenie działa jako pierwsze, przed pozostałymi filtrami, więc liczby na górze ekranu i tabela pod nimi zawsze mówią o tym samym zbiorze wizyt. Jeden ekran świadomie tę belkę ignoruje — raport dla grantodawcy — i pisze o tym wprost, bo sprawozdanie z dotacji musi obejmować całą działalność.

## Pulpit

Sześć liczb z ostatnich czterech tygodni: rezerwacje, przychód, obłożenie zespołu, odsetek odwołań, odsetek nieobecności i kwota zwrotów. Niżej dwa wykresy tydzień po tygodniu — osobno liczba wizyt, osobno pieniądze. Dalej pasek pokazujący, co się stało z umówionymi wizytami: ile się odbyło, ile odwołano w terminie, ile po terminie, ile było nieobecności i ile odwołań ze strony specjalistów. Na końcu ranking obłożenia poszczególnych osób i ścieżka pacjenta: ilu przyszło pierwszy raz, ilu wróciło, ile średnio sesji przypada na osobę i co ile dni ludzie się umawiają.

- ustawić osobny zakres dat dla każdej sekcji: 4 tygodnie, 12 tygodni, 26 tygodni albo rok
- rozwinąć pod wykresem tabelę z dokładnymi liczbami tydzień po tygodniu
- najechać na słupki i zobaczyć rozbieżności na wizyty niskopłatne i pełnopłatne
- wybrać sekcję i wydrukować je jako raport PDF

Zakres dat siedzi w każdej sekcji z osobna, a nie jeden na górze ekranu. „Ile mieliśmy wizyt w tym roku” i „jakie jest obłożenie w tym miesiącu” to dwa niezależne pytania, a wspólny filtr każe porzucić jedno z nich. Ceną jest raport, w którym sekcje mówią o różnych okresach — dlatego zakres jest wypisany w nagłówku każdej sekcji i powtórzony przy wydruku, a gdy wybrane sekcje mają różne okresy, pojawia się ostrzeżenie. Wizyty i zlotówki są na dwóch osobnych wykresach, nigdy na jednym: mają inną skalę i zestawione razem sugerowałyby zależność, której nie ma. Najważniejsza pojedyncza liczba to udział odwołań po terminie w ogóle odwołań — jeśli rośnie, problem jest w komunikacji, nie w regulaminie: pacjenci dowiadują się o zasadzie za późno.

## Grafik zespołu

Cały zespół w jednym dniu, godzina po godzinie: kolumna na osobę, w kratkach nazwisko pacjenta, skrót usługi i kwota. Ponieważ zespół liczy 111 osób, na ekranie mieści się 8 naraz — resztę wyszukuje się po nazwisku albo przewija stronami. Są jeszcze dwa inne ujęcia: tydzień jednej osoby oraz miesiąc całego zespołu bez nazwisk, gdzie każdy dzień to kafelek z obłożeniem. Na dole cztery liczby dla całego zespołu: ile wizyt jest tego dnia, ile zostało wolnych terminów, jaka jest wartość dnia i ilu specjalistów jest w systemie.

- przełączać się między dniem, tygodniem jednej osoby i miesiącem całego zespołu
- przesuwac się do przodu i do tyłu, a jednym przyciskiem wrócić do dzisiaj
- szukać specjalisty po nazwisku i zawężać widok do samych wizyt umówionych albo samych wolnych
- otworzyć wizytę i zobaczyć pacjenta, usługę, formę, zapłaconą kwotę oraz ile godzin zostało do terminu
- odwołać wizytę jako koordynator — pacjent dostaje wtedy pełny zwrot niezależnie od tego, ile zostało do terminu
- przenieść wizytę na inny termin, przypisać innego specjalistę albo zwrócić pieniądze mimo reguły 24 godzin
- umówić wizytę za osobę, która zadzwoniła, i wybrać, czy dostanie link do płatności, czy wizyta jest opłacona przelewem albo bezpłatna
- kliknąć dzień w widoku miesiąca, żeby otworzyć go godzina po godzinie

Trzy ujęcia zamiast jednego, bo przy 111 osobach jedno nie działa. Siatka „wszyscy razy godziny” czytelnie mieści 8 osób; siatka „wszyscy razy 7 dni” miałaby ponad 700 kolumn, więc tydzień pokazuje jedną osobę — i tak układa się grafik konkretnego terapeuty. Miesiąc nie pokazuje nazwisk w ogóle, bo służy do wyłapywania dziur w kalendarzu, a nie do sprawdzania, kto kiedy pracuje; dzień z ponad 85 procentami wykupionych godzin zapala się na żółto. Cztery liczby na dole zawsze liczą cały zespół, nie widoczną stronę — inaczej zmieniałyby się przy przewijaniu listy i nic by nie znaczyły. Wizyta umówiona przez telefon podlega tej samej regule 24 godzin co każda inna; odstępstwo wymaga świadomego kliknięcia „zwróć mimo reguły”.

## Zgłoszenia (pierwszy kontakt)

Kolejka osób, które wypełniły krótką ankietę na stronie i czekają na skierowanie do konkretnego specjalisty. Przy każdym zgłoszeniu widać, czego szuka (najwyżej dwa obszary z gotowej listy), czy była już kiedyś na terapii, czy woli online czy stacjonarnie, jak pilna jest sprawa według niej samej, ile godzin czeka i czy prosi o wizytę dofinansowaną. Na górze cztery liczby: ile zgłoszeń czeka, ile czeka dłużej niż dobę, ile osób samo oznaczyło sprawę jako pilną i ile wynosi typowy czas oczekiwania. Nazwiska są skrócone do inicjału, a numer telefonu jest zasłonięty kropkami.

- zawęzić kolejkę do spraw pilnych albo do czekających dłużej niż dobę
- otworzyć zgłoszenie i zobaczyć wszystkie sześć odpowiedzi z ankiety
- wybrać jedną z trzech propozycji specjalisty, które system dobiera po obszarach, formie pracy, mieście i pierwszym wolnym terminie
- zmienić rodzaj wizyty na niskopłatną albo pełnopłatną i zobaczyć cenę, jaką osoba zapłaci
- wskazać konkretną godzinę z najbliższych trzech dni pracy wybranej osoby
- wysłać jedną propozycję terminu — zgłoszenie znika z kolejki, a termin jest zablokowany na 2 dni
- odsłonić numer telefonu (odsłonięcie zostaje odnotowane) i poprosić o rozmowę zamiast wysłać termin

Ankieta ma sześć pytań z gotowymi odpowiedziami i ani jednego pola „opisz swój problem”. To nie przeoczenie: odpowiedzi o zdrowiu psychicznym są danymi szczególnie chronionymi, każde dodatkowe pole trzeba zabezpieczyć, przechować i po czasie usunąć, a formularz, który pyta o wszystko, zamyka się częściej, niż wysyła. Osoba, która pierwszy raz prosi o pomoc, opowiada swoją historię terapeutycznie, a nie stronie internetowej; gdy dwie odpowiedzi nie wystarczą do skierowania, tańsza jest rozmowa telefoniczna niż trzecie pytanie w ankiecie. System nie zaznacza żadnej propozycji z góry — podpowiedź, której nikt nie zmienia, zamienia kwalifikację w automat z ludzkim podpisem. Ekran istnieje po to, żeby czytanie 111 biogramów przenieść z osoby w kryzysie na koordynatora; kosztem jest doba zwłoki, którą ten ekran mierzy i pokazuje.



## Rezerwacje

Lista wszystkich wizyt z numerem, pacjentem, specjalistą, terminem, rodzajem usługi, kwotą i statusem. Przy kwocie od razu widać, co się stało z pieniędzmi: „zwrot do wykonania”, „bez zwrotu” albo „nieopłacone”. Na górze cztery liczby: ile wizyt jest dzisiaj, ile czeka na płatność, ile zwrotów jest w toku i ile było nieobecności w ostatnich dwóch tygodniach. Nad tabelą stoją filtry i przyciski statusów, a przy każdym przycisku liczba mówiąca, ile pozycji zobaczysz po kliknięciu.

- szukać po numerze rezerwacji albo nazwisku pacjenta
- zawężać po okresie, specjalście, usłudze, formie wizyty i statusie
- otworzyć historię jednej rezerwacji: kto ją założył, kiedy przyszła płatność, kiedy poszło potwierdzenie i przypomnienie, kto i kiedy odwołał, ile trzeba zwrócić
- wysłać potwierdzenie jeszcze raz, gdy pacjent go nie znalazł
- pobrać listę do arkusza
- wyczyścić wszystkie filtry jednym przyciskiem

Liczby przy przyciskach statusów liczą się z aktualnie zawężonej listy, a nie z całej bazy. Przycisk, który obiecuje 12 odwołanych, a po kliknięciu pokazuje pustą tabelę, uczy nie ufać żadnej liczbie na ekranie. Tabela pokazuje 60 pozycji i wprost pisze, ile jeszcze zostało — ciche ucięcie listy czyta się jak „to wszystko, co jest”. Historia rezerwacji wypisuje wyłącznie to, co się już wydarzyło; nie ma tam przypomnienia, które dopiero pójdzie, ani płatności przy wizycie, która czeka na opłacenie. Czego tu celowo nie ma: treści rozmów i notatek z sesji. Koordynator widzi organizację wizyty i pieniądze, nie to, o czym ona była.

## Pacjenci

Kartoteka osób, które miały wizyty w ostatnich 120 dniach: kto je prowadzi, ile miały wizyt, jaka jest ich frekwencja, ile z 10 wizyt niskopłatnych już wykorzystały i ile dostały bezpłatnie. Pasek przy każdej osobie robi się żółty w momencie wyczerpania limitu. Na górze: ilu pacjentów jest w bazie, u ilu limit się skończył, ile wizyt niskopłatnych wykorzystano razem i jaki odsetek osób wraca po pierwszej wizycie.

- szukać pacjenta po imieniu i nazwisku
- pokazać tylko osoby z wyczerpanym limitem wizyt niskopłatnych
- otworzyć kartę pacjenta: wizyty odbyte, odwołane, nieobecności, prowadzący, wszyscy specjaliści, u których był, i suma wpłat
- zwiększyć limit o 4 wizyty niskopłatne — pacjent dostaje o tym maila
- umówić wizytę za pacjenta

Prowadzącego nikt nie przypisuje ręcznie i nie ma ekranu „przypisz psychologa” — zostaje nim specjalista pierwszej odbytej wizyty. Umówienie się u kogoś innego jest dozwolone i niczego nie zmienia, bo przy pomocy w kryzysie liczy się najbliższy wolny termin, a nie ciągłość opieki; trwała zmiana prowadzącego wymaga potwierdzenia koordynatora. Decyzja o podniesieniu limitu zostaje w historii pacjenta razem z nazwiskiem osoby, która ją podjęła. Wizyty bezpłatne mają własną kolumnę, bo inaczej nikt nie wie, komu i ile fundacja już przyznała. Kartoteka odpowiada na pytania organizacyjne — ile wizyt, jaka frekwencja, ile zostało — a nie na pytanie, o czym pacjent rozmawia z terapeutą.

## Lista rezerwowa

Dwie listy. Górna to terminy, które się zwolniły: kiedy, u kogo, jaki rodzaj wizyty, ile godzin przed spotkaniem pacjent odwołał i czy udało się je obsadzić ponownie. Dolna to kolejka osób czekających na wolny termin, ustawiona według czasu oczekiwania, z informacją, ile razy ktoś dostał już propozycję i jej nie przyjął oraz czy zgadza się na termin w ciągu doby. Na górze cztery liczby: ile osób czeka, jaka jest skuteczność odzysku, ile pieniędzy udało się odzyskać i ile mimo wszystko przepadło.

- zawęzić obie listy do jednego specjalisty
- podejrzeć trwającą propozycję: komu poszła, ile czasu jej zostało i kto jest następny w kolejce
- przekazać propozycję dalej ręcznie, gdy wiadomo, że pierwsza osoba jest nieosiągalna

Gdy pacjent odwoła wizytę później niż 24 godziny przed terminem, godzina zwykle przepada, a specjalista i tak dostaje za nią wynagrodzenie — ta lista jest sposobem, żeby ten czas odzyskać. Propozycja idzie mailem i SMS-em jednocześnie, a pierwsza osoba ma 4 godziny na odpowiedź; potem termin przechodzi do następnej bez udziału koordynatora. Cztery godziny to kompromis: doba ważności marnuje termin zwolniony na jutro, bo wizyta minie, zanim propozycja wygaśnie, a kwadrans karze za to, że ktoś jest akurat w pracy albo na sesji. Zegar zatrzymuje się między 21:00 a 8:00, żeby propozycja wysłana wieczorem nie wygasła, zanim ktokolwiek się obudzi.

## Psycholodzy

Tabela całego zespołu: jakie usługi dana osoba przyjmuje, jaką ma stawkę, ile godzin wystawiła, jakie ma obłożenie, ile wizyt odwołała w ostatnich 30 dniach, jaka jest frekwencja jej pacjentów oraz wpływy razem z prowizją fundacji. To jedyne miejsce z pełnym rozliczeniem — specjalista w swoim panelu widzi wyłącznie kwotę, którą dostanie. Nad tabelą pojawia się ostrzeżenie, gdy ktoś odwołał więcej niż 10 wizyt w 30 dni. Niżej dwie krótsze listy: kto ma kalendarz otwarty krócej niż na 21 dni i które usługi wymagają osobnej zgody fundacji.

- zaprosić nową osobę do zespołu — konto powstaje po ustawieniu przez nią hasła
- otworzyć ustawienia specjalisty: włączyć albo wyłączyć poszczególne usługi, nadpisać stawkę pełnopłatną, zawiesić konto
- wysłać prośbę o zwolnienie terminów z podaniem powodu i zakresu godzin
- przypomnieć o uzupełnieniu dostępności
- napisać do osoby, która dużo odwołuje, albo wyciszyć ten sygnał na 30 dni
- pobrać pełny raport o zespole

Sygnał o odwołaniach liczy sztuki w oknie 30 dni, a nie procent od początku współpracy. Licznik „od zawsze” przekroczyłby dziesiątkę u każdej aktywnej osoby w ciągu roku i przestałby cokolwiek znaczyć, a „12 procent odwołań” u kogoś z trzema wizytami i u kogoś ze stu to zupełnie inna sprawa — rozmowę trzeba odbyć z tą drugą. Treść jest napisana jako zaproszenie do rozmowy, nie jako kara: dziesięć odwołań w miesiącu prawie zawsze znaczy, że po drugiej stronie dzieje się coś, czego nie widać w grafiku. Prośba o zwolnienie terminów jest prośbą, nie poleceniem — fundacja nie zdejmuje godzin z cudzego grafiku poza sytuacją ratowania pacjenta. Odebranie usługi nie kasuje już umówionych wizyt: one się odbędą, zniknie tylko możliwość rezerwowania nowych.

## Wdrożenia

Lista osób zaproszonych do współpracy i tego, na czym każda z nich stoi. Ścieżka ma siedem kroków: zaproszenie, konto, dane i umowa, konto bankowe, uprawnienia do usług, pierwszy grafik i pierwsza wizyta. Najważniejsza kolumna to nie postęp, tylko „przyjmuje pacjentów” — ktoś z sześcioma krokami z siedmiu może być jeszcze niedostępny, a ktoś z pięcioma już przyjmować. Widać też, kto trzyma sprawę (specjalista, fundacja czy pacjent) i od ilu dni nic się nie ruszyło. Niżej dwie sekcje: w którym kroku najczęściej stoją ludzie oraz który brak co blokuje.

- zaprosić kolejną osobę
- zawęzić listę do spraw czekających na fundację, na specjalistę, stojących dłużej niż 14 dni albo takich, gdzie nikt jeszcze nie może przyjmować pacjentów
- otworzyć kartę osoby i zobaczyć wszystkie siedem kroków z datami zamknięcia
- wysłać jedno przypomnienie obejmujące wszystkie brakujące u tej osoby rzeczy
- zatwierdzić krok po stronie fundacji, w tym nadać uprawnienia do usług

Kroki nie ważą tyle samo i to jest sedno tego ekranu. Brak podpisanej umowy zatrzymuje wszystko, bo bez niej fundacja nie ma podstawy do powierzenia komuś danych osoby w kryzysie. Brak numeru konta nie dotyka pacjenta w żaden sposób — wynagrodzenie nalicza się dalej i czeka na przelew — więc wstrzymywanie z tego powodu wizyt byłoby ukaraniem pacjenta za cudzą zaległość papierową. Uprawnienie do diagnozy ADHD idzie osobno, bo wymaga sprawdzenia dyplomu, i nie wstrzymuje pozostałych usług tej osoby. Przypomnienie zbiera wszystkie braki naraz, bo osoba, która dostaje trzy osobne maile w tygodniu, przestaje je czytać. Jediną akcją wobec specjalisty jest przypomnienie, nigdy automatyczne zamknięcie sprawy: system odróżni „czeka od 30 dni” od „zrobione”, ale nie odróżni osoby, która się rozmyśliła, od tej, która zgubiła maila.

## Grupy i warsztaty

Lista wszystkich spotkań grupowych z terminem, prowadzącymi, liczbą zajętych miejsc, ceną i statusem. Pasek przy każdym spotkaniu robi się żółty, gdy miejsca się skończyły, a pod nim widać, ile osób czeka na liście rezerwowej. Na górze cztery liczby: ile spotkań jest przed nami, jakie jest obłożenie miejsc, ile osób czeka na zwolnienie miejsca i ile wpłat przyniosły płatne warsztaty.

- utworzyć nowe spotkanie: rodzaj, forma, nazwa, opis, data, godzina, czas trwania, liczba spotkań w cyklu, rytm, limit miejsc, miejsce i cena
- przypisać jedną albo kilka osób prowadzących — każda zobaczy spotkanie w swoim panelu razem z listą uczestników
- otworzyć listę uczestników i listę rezerwową
- przenieść osobę z listy rezerwowej na wolne miejsce albo wypisać uczestnika
- podnieść limit miejsc, gdy sala pomieści więcej — osoby z listy awansują natychmiast i dostają maila
- pobrać listę uczestników do arkusza i pełny raport o grupach

Termin, limit i prowadzących ustala fundacja, a nie specjalista — dlatego tworzenie spotkań jest wyłącznie tutaj, inaczej niż przy wizytach jeden na jeden, gdzie godziny wystawia sam specjalista. Rezygnacja z grupy jest możliwa do 2 godzin przed spotkaniem, czyli krócej niż 24 godziny przy konsultacjach: miejsce w grupie da się jeszcze przekazać komuś z listy rezerwowej, a potem prowadzący ma już ustalony skład i liczy na obecność. Po wyczerpaniu miejsc zapisy się nie zamykają — chętni trafiają na listę i awansują sami, gdy ktoś zrezygnuje.

## Wiadomości

Skrzynka rozmów prowadzonych w trzech kierunkach: pacjent ze specjalistą, specjalista z koordynacją, pacjent z koordynacją. Po lewej lista wątków, każdy z nazwą, kontekstem (numer wizyty albo nazwa grupy) i początkiem ostatniej wiadomości, z licznikiem nieprzeczytanych. Po prawej otwarta rozmowa i pole do napisania odpowiedzi.

- otworzyć dowolny wątek i przeczytać całą rozmowę
- odpisać — odbiorca dostaje powiadomienie mailem

Każdy wątek ma przypisany kontekst, czyli numer wizyty albo nazwę grupy. Bez tego po trzech tygodniach nikt nie pamięta, czego rozmowa dotyczyła, a moduł zamienia się w drugą skrzynkę mailową, z której nikt nie korzysta. Na ekranie stoi ostrzeżenie widoczne dla koordynacji i specjalistów: to nie jest kanał kryzysowy, wiadomości czyta się w godzinach pracy, a przy zagrożeniu życia reaguje się telefonicznie i podaje numery kryzysowe.

## Faktury specjalistów

Lista faktur przysłanych przez specjalistów, ustawiona od tych, które czekają najdłużej. Przy każdej widać okres, liczbę rozliczanych wizyt, kwotę z faktury i to, czy zgadza się ona z wyliczeniem systemu — a jeśli nie, o ile się różni. Na górze cztery liczby: ile faktur czeka na sprawdzenie i na jaką kwotę, ile zaakceptowano do wypłaty, ile odesłano do poprawy i przy ilu jest rozjazd wymagający wyjaśnienia.

- zawęzić listę do faktur czekających, zaakceptowanych, do poprawy albo opłaconych
- otworzyć fakturę, obejrzyć dokument i porównać kwotę z wyliczeniem systemu
- zaakceptować fakturę do wypłaty w najbliższej paczce przelewów
- poprosić o korektę z konkretnym opisem tego, co wymaga poprawy

Krok sprawdzenia nie jest formalnością i chroni przede wszystkim specjalistę. Kwota z faktury bywa niższa od rozliczenia systemu, bo specjalista liczy z własnego kalendarza i pomija godziny opłacone mimo nieobecności pacjenta.

Automatyczna akceptacja oznaczałaby, że fundacja płaci mniej, niż powinna, a druga strona dowiadyuje się o tym po miesiącach albo nigdy. Status nazywa się „do poprawy”, a nie „odrzucona” — odrzucenie brzmi jak zarzut, a w dziewięciu przypadkach na dziesięć chodzi o pomyłkę w arytmetyce i o człowieka, z którym fundacja chce dalej pracować. System nie wystawia faktur za specjalistów, bo rozliczają się na różnych zasadach i dokument musi wychodzić z ich własnej księgowości; podpowiada tylko kwotę wynagrodzenia.

## Historia decyzji

Dziennik wszystkich decyzji podjętych poza regułami systemu: wizyta bezpłatna, podniesienie limitu, zwrot mimo przekroczenia 24 godzin, ręczna zmiana prowadzącego i zdjęcie blokady. Przy każdym wpisie widać datę, kogo dotyczy, przy której rezerwacji zapadła, uzasadnienie, nazwisko osoby, która ją podjęła, i skutek dla budżetu. Na górze cztery liczby, w tym dwie osobne kwoty: pieniądze, które już wyszły, i zobowiązania, czyli podniesione limity, które kosztują dopiero wtedy, gdy pacjent te wizyty wykorzysta.

- ustawić okres na 30, 90 albo 180 dni
- zawęzić do jednego rodzaju decyzji albo do jednej osoby z koordynacji
- otworzyć wpis i przeczytać pełne uzasadnienie razem z informacją, czy został później sprostowany
- dopisać uzasadnienie do wpisu, który go nie ma — jako nowa pozycja z dzisiejszą datą
- dodać sprostowanie do decyzji, która okazała się błędna
- wydrukować całość jako załącznik do sprawozdania

Wpisu nie da się zmienić ani usunąć i nigdzie na tym ekranie nie ma przycisku „edytuj” ani „usuń”, także w oknie szczegółów, gdzie szuka się go odruchowo. Dziennik ma jedną operację: dopisanie. Powód nie jest ideologiczny — zapis, który wolno zmienić wstecz, przy rozliczeniu dotacji nie jest dowodem, tylko notatnikiem, bo kontroler nie odróżni uzasadnienia napisanego w dniu decyzji od dopisanego w noc przed kontrolą. Kosztem jest to, że literówka zostaje na zawsze, a poprawka wymaga drugiego wpisu. Pieniądze wydane i zobowiązania nigdy nie są sumowane w jedną liczbę: sprawozdanie z dotacji rozlicza wydatki, a nie deklaracje.

## Raport dla grantodawcy

Komplet liczb do sprawozdania z dotacji za zamknięty kwartał albo rok: ile osób objęto pomocą, ile z nich przyszło pierwszy raz, ile odbyło się wizyt, ile z nich było dofinansowanych i ile fundacja do nich dołożyła. Niżej rozbiecie wizyt na dofinansowane, pełnopłatne i bezpłatne, podział na osoby nowe i kontynuujące, zestawienie środków fundacji, najczęstsze obszary problemowe i tabela wskaźników — każdy z kolumną mówiącą, jak dokładnie jest liczony. Na końcu rozbiecie roku na cztery kwartały razem ze zdaniem wyjaśniającym, dlaczego kwartały nie sumują się do roku.

- wybrać rok i okres: konkretny kwartał albo cały rok (bieżący, niezakończony kwartał jest niedostępny)
- otworzyć gotowe zestawienie z nazwami pozycji takimi, jak w formularzu sprawozdania
- skopiować zestawienie i wkleić je do formularza
- pobrać raport jako PDF

Główną liczbą jest osoba, a nie wizyta, i to dwie różne liczby: 900 wizyt brzmi lepiej niż 280 osób, ale grantodawca finansuje zasięg pomocy, nie ruch w kalendarzu. Wynika z tego rzecz nieoczywista, dlatego wypisana na ekranie wprost: osób z czterech kwartałów nie wolno dodawać do roku, bo ta sama osoba wraca w kolejnym kwartale i w raporcie rocznym liczy się raz; wizyty wolno dodawać, osób nie. Okres to zawsze zamknięty kwartał albo rok, nigdy „ostatnie 30 dni” — sprawozdanie złożone z ruchomego okna trzeba by korygować przy każdej zmianie w grafiku. „Objęta pomocą” znaczy co najmniej jedna odbyta wizyta: osoba, która wszystko odwołała, nie wchodzi do sprawozdania. Raport nie zawiera żadnych nazwisk ani powodów zgłoszenia pojedynczych osób i nie mówi nic o efektach terapii — system wie, ile spotkań się odbyło, i nie wie, co dały.

## Katalog usług

Wszystkie usługi fundacji, jedna pod drugą: nazwa, opis, czas trwania, cena albo lista dozwolonych stawek, ilu specjalistów daną usługę przyjmuje, jaka jest prowizja i kto ustala cenę. Usługa, której nikt nie przyjmuje, jest wyraźnie oznaczona. Widać też, które pozycje wymagają osobnej zgody fundacji.

- dodać nową usługę do katalogu
- zmienić nazwę, czas trwania, model ceny i dozwolone stawki
- zdecydować, czy usługa wymaga osobnego uprawnienia, czy fundacja pobiera od niej prowizję i czy jest widoczna w wyszukiwarce dla pacjentów

Cennik powstaje w jednym miejscu i należy do fundacji — specjalista wybiera tylko, które usługi przyjmuje, a jedyny wyjątek to stawka pełnopłatna wybierana z gotowej listy kwot. Zmiana ceny nigdy nie dotyczy wizyt już opłaconych: rezerwacja pamięta kwotę z dnia zakupu, więc zwrot zawsze równa się temu, co pacjent naprawdę zapłacił. Bez tego podniesienie cennika o 10 zł sprawiłoby, że stare zwroty przestałyby się zgadzać z operatorem płatności.

## Powiadomienia SMS

Wszystkie treści SMS, które system wysyła sam, z podglądem na ekranie telefonu — dokładnie w takiej postaci, w jakiej zobaczy je pacjent. Przy każdym szablonie widać, co go wyzwało, ile razy poszedł w ostatnich 30 dniach i na ile wiadomości się rozpada. Na górze koszt miesięczny i liczba szablonów, które nie mieszczą się w jednej wiadomości. Niżej krótka historia ostatnich wysyłek z przyciętymi numerami telefonów.

- przejrzeć wszystkie szablony i przeczytać ich pełną treść
- zawęzić listę do jednej kategorii wiadomości
- zobaczyć, ile znaków ma wiadomość i na ile części się rozpada
- wysłać wiadomość testową na wskazany numer

Ekran istnieje po to, żeby fundacja przeczytała te treści przed wdrożeniem — uwagi do słów zbiera się tanio teraz, a drogo po podpisaniu umowy z operatorem. Przy okazji policzył koszt, o którym nikt nie pomyślał: polskie znaki wypychają wiadomość z alfabetu, w którym mieści się 160 znaków, do takiego, gdzie mieści się 70, a każda część to osobna opłata. To 136 zł miesięcznie, czyli 46 procent rachunku. Nie zalecamy pisania bez ogonków — wiadomość od fundacji pomocowej wygląda wtedy jak spam i to może kosztować więcej niż te złotówki; tańsza droga to skrócenie treści, bo trzy szablony przekraczają limit o kilkanaście znaków. Osobna zasada: w SMS-ach nie ma ani słowa o zdrowiu, nazwie usługi ani specjalizacji, bo wiadomość wyświetla się na zablokowanym ekranie, często przy innych ludziach.

## Szablony maili

Wszystkie treści maili, które system wysyła sam — do pacjentów, specjalistów i koordynacji. Po lewej lista szablonów z informacją, do kogo idą, ile razy poszły w ostatnich 30 dniach i czy ktoś je już zmieniał. Po prawej podgląd gotowej wiadomości z wypełnionymi danymi przykładowego pacjenta, dokładnie taki, jaki trafi na skrzynkę.

- przejrzeć szablony i zawęzić listę do jednej kategorii
- zmienić temat i treść dowolnego maila bez udziału programisty
- wstawić do treści jedną z gotowych wartości, na przykład imię, datę albo kwotę
- przywrócić treść domyślną
- wysłać wiadomość testową na własny adres

Maile fundacja zmienia sama, SMS-y nie — i to podział wynikający z kosztu, nie z ostrożności. SMS ma sztywny limit znaków i płaci się za każdą część, więc dopisanie jednego zdania potrafi podwoić rachunek za wysyłkę idącą codziennie do wszystkich pacjentów; mail nie ma tego ograniczenia, a to właśnie w mailach najczęściej trzeba coś dopisać. Ceną tej swobody jest ryzyko wysłania trzystu osobom maila z napisem „{imie}”, dlatego edytor sprawdza wstawiane wartości i nie pozwala zapisać treści z nazwą, której system nie umie podstawić. Świadomie nie ma tu edytora z kolorami i obrazkami: maile transakcyjne mają dotrzeć i dać się przeczytać także na starym telefonie, a rozbudowany wygląd potrafi wylądować w spamie albo rozjechać się tak, że nie widać godziny wizyty.

## Zakres wdrożenia

Dokument, a nie pulpit: rozpiska tego, co system ma robić i co trzeba zbudować, żeby zadziałał naprawdę. Podzielona na moduły, każdy z celem, listą ekranów w makiecie, zadaniami rozbitymi na konkretne czynności, regułami obowiązującymi w module i ustaleniami projektowymi. Przy zadaniach są zależności i ryzyka. Na górze cztery liczby: ile jest modułów, ekranów, zadań i podzadań.

- rozwijać i związać poszczególne moduły
- szukać w treści zadań, na przykład po słowie „płatności” albo „RODO”
- zawęzić do jednej warstwy prac
- pobrać całość jako PDF do wysłania

Dokument świadomie nie zawiera godzin ani kwot. Zakres i wycena odpowiadają na dwa różne pytania i zmieniają się w innym tempie: zakres jest stały (te funkcje system ma mieć), a wycena zależy od kolejności wdrażania, od tego, ile fundacja robi sama, i od terminu. Liczba wpisana obok zadania zaczyna żyć własnym życiem i wraca w rozmowie jako zobowiązanie. Nie ma tu też przenoszenia danych z obecnych narzędzi fundacji — zakres tej pracy zależy od tego, co dokładnie trzeba przenieść, a tego jeszcze nie ustaliliśmy.

## Reguły systemu

Jedno miejsce, w którym zapisane są wszystkie zasady, które system potem wykonuje bez pytania kogokolwiek o zdanie. Najpierw czas: do kiedy odwołanie jest bezpłatne, ile razy można przełożyć wizytę, jak wcześniej najwcześniej można się umówić, na ile dni otwarty jest kalendarz, ile trwa przerwa między wizytami i jak długo termin jest trzymany podczas płatności. Potem tabela ośmiu sytuacji z odpowiedzią, co się dzieje ze zwrotem, z terminem i z wynagrodzeniem specjalisty. Dalej pieniądze — prowizje i tryb wypłat — oraz lista powiadomień z zaznaczeniem, które idą mailem, a które SMS-em.

- zmienić którąkolwiek z wartości czasowych
- ustawić prowizję od wizyt pełnopłatnych i niskopłatnych oraz częstotliwość wypłat
- włączyć albo wyłączyć kredyt za odsprzedany termin
- zdecydować, które powiadomienia idą mailem, a które także SMS-em
- zapisać reguły — obowiązują od nowych rezerwacji

Tabela ośmiu sytuacji to cała polityka odwołań i nie ma w niej miejsca na uznaniowość: żaden inny ekran nie decyduje o zwrocie samodzielnie, a wyjątki robi człowiek przyciskiem „zwróć mimo reguły” i zostawia po sobie ślad w dzienniku decyzji. Zmiana reguły nigdy nie działa wstecz — wizyty już opłacone zachowują zasady z dnia zakupu, bo pacjent zgodził się na konkretne warunki. Przypomnienie 24 godziny przed wizytą jest nieprzypadkowe: wypada dokładnie w momencie zamykania okna bezpłatnej rezygnacji, więc pacjent dowiaduje się o zasadzie wtedy, kiedy może jeszcze coś z tym zrobić. Bez tego maila reguła 24 godzin generuje same skargi. Otwarte pozostaje jedno: czy te 24 godziny liczyć zegarowo, także przez weekend (tak jest dzisiaj), czy w dniach roboczych — wtedy wizytę w poniedziałek rano trzeba by odwołać do piątku. To decyzja regulaminowa, nie techniczna.

## Zasady obowiązujące w tym obszarze



**Odwolanie i zmiana terminu są bezpłatne do 24 godzin przed wizytą. Później przyciski znikają z ekranu pacjenta.**

Specjalista rezerwuje tę godzinę wyłącznie dla jednej osoby i nie przyjmie w niej nikogo innego. Doba to tyle, ile realnie potrzeba, żeby ktoś inny znalazł ten termin i z niego skorzystał. Przyciski znikają, a nie są wyszarzone — wyszarzony przycisk kusi, żeby go klikać i szukać sposobu obejścia.

**Wizyta odwołana później niż 24 godziny przed terminem nie podlega zwrotowi, a specjalista dostaje za tę godzinę wynagrodzenie.**

Zablokował na nią czas i nie mógł przyjąć nikogo innego. Fundacja nie może przerzucić tego kosztu na osobę, która przyszła do pracy i czekała.

**Termin odwołany po czasie i tak wraca do puli wolnych godzin, mimo że pacjent nie dostaje zwrotu.**

Zdarza się, że ktoś inny go wykupi, a lepiej, żeby godzina się odbyła, niż stała pusta. Osoba, która odwołała, nie płaci za nią drugi raz — jeśli termin zostanie odsprzedany, dostaje równowartość jako kredyt na kolejną wizytę.

**Zmiana terminu później niż 24 godziny przed wizytą jest niedostępna — tak samo jak odwołanie.**

Gdyby zostawić tę furtkę, nikt by nie odwoływał — wszyscy przekładaliby wizyty, godzina i tak by przepadała, a okno 24 godzin przestałoby cokolwiek znaczyć. Tak samo rozwiązują to inne systemy rezerwacji wizyt: późne przełożenie jest równoznaczne z późnym odwołaniem.

**Jedną rezerwację można przełożyć najwyżej 2 razy.**

Trzecia zmiana terminu zwykle znaczy, że ten termin po prostu nie pasuje. Lepiej odwołać wizytę i wybrać nową, niż blokować godzinę specjalisty w nieskończoność.

**Najbliższy termin, jaki można zarezerwować, to 2 godziny od teraz.**

Osoba, która rano czuje, że musi z kimś porozmawiać, może umówić się jeszcze tego samego dnia. To świadomy wybór na rzecz osób w kryzysie, kosztem tego, że specjalista dowiaduje się o wizycie na ostatnią chwilę.

**Kalendarz dla pacjenta jest otwarty na 30 dni w przód.**

Dalej niż na miesiąc mało kto planuje wizytę u psychologa, a długi kalendarz kusi do rezerwowania terminów, które potem trzeba odwoływać.

**Specjalista wystawia swoje godziny najwyżej 7 dni do przodu — panel blokuje dalsze daty.**

Fundacja chce mieć pewność, że grafik pokazuje realną dostępność, a nie deklaracje sprzed miesiąca. Termin sprzed czterech tygodni bardzo często okazuje się już nieaktualny, a pacjent dowiaduje się o tym dopiero po rezerwacji.

**Każdemu pacjentowi przysługuje 10 wizyt niskopłatnych po 55 zł.**

Fundacja pokrywa różnicę do pełnej stawki z dotacji, a ta jest skończona. Liczymy spotkania, nie minuty: „3 z 10 wizyt” nie wymaga tłumaczenia, a „pozostało 1 godzina 40 minut” kończy się telefonem do koordynatora.

**Po wyczerpaniu 10 wizyt niskopłatnych pacjent nie traci dostępu do pomocy — przechodzi na wizyty pełnopłatne albo prosi koordynatora o zwiększenie puli.**

Limit dotyczy dofinansowania, nie prawa do pomocy. Nikogo nie odsyłamy z niczym, mówimy tylko, że kolejne spotkania są w innej cenie.

**Koordynator podnosi limit skokiem o 4 wizyty, a decyzja zostaje w historii pacjenta razem z jego nazwiskiem i uzasadnieniem.**

Fundacja musi umieć powiedzieć przy kontroli dotacji, komu i dlaczego przyznała więcej, niż przewiduje reguła. Bez zapisanego uzasadnienia ten wydatek może nie zostać uznany.

**Jeden specjalista może wystawić 4 terminy niskopłatne tygodniowo, a blokada działa przy układaniu grafiku, nie przy rezerwacji.**

Pula dofinansowania jest skończona, więc fundacja steruje nią przy wystawianiu godzin. Gdyby ograniczenie działało dopiero przy rezerwacji, pacjent widziałby wolny termin i dostawał odmowę przy płatności — w najgorszym możliwym momencie, po podjęciu decyzji i wyjęciu karty.

**Kto zaczął leczenie niskopłatnie, rezerwuje kolejne wizyty w tej samej kategorii — u tego samego albo innego specjalisty — dopóki nie wykorzysta 10 wizyt.**

Chodzi o to, żeby dofinansowanie szło na proces terapeutyczny, a nie na pojedyncze spotkania rozrzucone po zespole.

**Przy rezerwacji na stronie termin jest trzymany 10 minut na czas płatności; potem wraca do puli.**

Osoba, która ma kartę pod ręką, płaci w minutę. Dziesięć minut wystarcza z zapasem, a dłuższa blokada oznacza, że wolne godziny znikają z kalendarza dla ludzi, którzy naprawdę chcą się umówić.

**Termin umówiony przez specjalistę po sesji albo zaproponowany przez koordynatora czeka na opłacenie 2 dni.**

Sytuacja jest inna niż przy rezerwacji na stronie: pacjent nie siedzi przy komputerze z kartą, tylko wychodzi z gabinetu i dostaje link mailem. Dwa dni to weekend plus dzień roboczy — mieści się w tym osoba, która płaci przelewem po wypłacie.

**Między wizytami jest 10 minut przerwy.**

Bez przerwy pierwsza spóźniona wizyta przesuwca cały dzień, a specjalista nie ma chwili na zapisanie czegokolwiek ani na złapanie oddechu między dwiema trudnymi rozmowami.

**Fundacja pobiera 20 procent od wizyt pełnopłatnych i 0 procent od niskopłatnych. Specjalista widzi w swoim panelu wyłącznie kwotę, którą dostanie.**

Przy wizytach niskopłatnych fundacja dopłaca z dotacji, więc nie ma od czego brać prowizji. Pełne rozliczenie — wpływ, prowizja, marża — jest widoczne tylko dla koordynacji, bo tak ustalono zasady współpracy.

**Więcej niż 10 odwołań ze strony jednego specjalisty w oknie 30 dni zapala sygnał u koordynatora.**

Taka liczba prawie zawsze znaczy, że po drugiej stronie dzieje się coś, czego nie widać w grafiku: choroba, przeciążenie, zbyt gęsto ułożony tydzień. Sygnał ma dotyczyć tego, co dzieje się teraz, dlatego okno to 30 dni, a nie cała historia współpracy — licznik „od zawsze” przekroczyłby dziesiątkę u każdej aktywnej osoby w ciągu roku i przestałby cokolwiek znaczyć.

**Zwroty wykonuje człowiek, klikając je w panelu płatności. System nigdzie nie pisze „zwrot wykonany”, tylko „zwrot do wykonania”, i pokazuje listę zadań.**

Automatyczne zwroty wymagałyby ciągłego uzgadniania stanu między systemem a operatorem płatności oraz obsługi zwrotów nieudanych i częściowych — czyli najdroższego kawałka całej integracji. Przy kilkudziesięciu zwrotach miesięcznie ręczne kliknięcie jest tańsze niż utrzymywanie tej automatyki.

**Z grupy i warsztatu można zrezygnować bezpłatnie do 2 godzin przed spotkaniem; wtedy też zamykają się zapisy.**

Krócej niż 24 godziny przy wizytach jeden na jeden, bo miejsce w grupie da się jeszcze przekazać komuś z listy rezerwowej. Po tym czasie prowadzący ma już ustalony skład i przygotowuje spotkanie pod konkretne osoby.

**Osoba z listy rezerwowej ma 4 godziny na przyjęcie zwolnionego terminu, a zegar zatrzymuje się między 21:00 a 8:00.**

Jak Propozycja ważna do 20:00 marnuje termin zwolniony na jutro — wizyta minie, zanim wygaśnie. Kwadrans z koleżanką za to, że ktoś jest akurat w pracy albo na sesji. Cztery godziny mieszczą się w dniu pracy i pozwalają przejść przez

trzy osoby w kolejce, a nocna przerwa istnieje po to, żeby nie karać ludzi za sen.

**Zgłoszenie z ankiety wstępnej powinno dostać odpowiedź w ciągu 24 godzin — po tym czasie zapala się na ekranie koordynatora.**

To zobowiązanie fundacji wobec osoby, która pierwszy raz poprosiła o pomoc. Nikogo nie blokuje, ale wprost pokazuje, gdzie fundacja przestała dotrzymywać własnej obietnicy.

**Zgłoszenie oznaczone jako „bez pośpiechu” wyprzedza świeże „pilne” po 48 godzinach czekania.**

Sama deklaracja pilności premiuje osoby, które potrafią głośno poprosić, a przy pierwszym kontakcie z pomocą to często najbardziej zmęczeni zaznaczają „bez pośpiechu”. Dzięki tej regule nikt nie zostaje w kolejce na zawsze tylko dlatego, że nie chciał robić kłopotu.

**Uzasadnienie decyzji uznaniowej krótsze niż 40 znaków jest oznaczane jako „do uzupełnienia”.**

Przy rozliczeniu dotacji różnica między „prośba pacjenta” a „utrata pracy, przejście na pełną odpłatność przerwałoby terapię” decyduje o tym, czy wydatek zostanie uznany. Próg mierzy długość, nie treść — ma przypominać o obowiązku, a nie udawać kontrolę jakości.

**Dziennik decyzji ma dokładnie jedną operację: dopisanie. Wpisu nie da się zmienić ani usunąć, a poprawka jest nowym wpisem z dzisiejszą datą.**

Zapis, który wolno zmienić wstecz, nie jest dowodem, tylko notatnikiem — kontroler nie odróżni uzasadnienia napisanego w dniu decyzji od dopisanego w noc przed kontrolą. Kosztem jest to, że literówka zostaje w systemie na zawsze.

**Wdrożenie nowego specjalisty ma 7 kroków: 5 z nich wstrzymuje przyjmowanie pacjentów, brak numeru konta wstrzymuje wyłącznie wypłatę, a pierwsza wizyta nie blokuje niczego. Sprawa bez ruchu dłużej niż 14 dni trafia na listę do interwencji.**

Bez podpisanej umowy fundacja nie ma podstawy do powierzenia komuś danych osoby w kryzysie — tego kroku nie da się przesunąć na później. Brak numeru konta nie dotyczy pacjenta w żaden sposób: wynagrodzenie nalicza się dalej i czeka na przelew, więc wstrzymywanie z tego powodu wizyt byłoby ukaraniem pacjenta za cudzą zaległość papierową.

**Specjalista z kalendarzem otwartym krócej niż na 21 dni trafia na listę do przypomnienia, a dzień, w którym zespół wykupił ponad 85 procent wystawionych godzin, zapala się w grafiku na żółto.**

Osoba z krótko otwartym kalendarzem jest dla szukającego pacjenta niedostępna, nawet jeśli realnie ma wolne godziny. Dzień pod korek oznacza z kolei, że warto poprosić kogoś o dołożenie terminów, zanim ludzie zaczną odchodzić z niczym.

**Raport dla grantodawcy obejmuje wyłącznie zamknięty kwartał albo rok, a liczby osób z 4 kwartałów nie sumują się do roku.**

Dotacje rozlicza się w okresach kalendarzowych, a sprawozdanie złożone z trwającego kwartału trzeba by potem korygować. Ta sama osoba wraca w kolejnym kwartale i w raporcie rocznym liczy się raz — wizyty wolno dodawać, osób nie.

**Zmiana reguły albo ceny obowiązuje tylko nowe rezerwacje: przesunięcie okna z 24 na 48 godzin ani podniesienie ceny o 10 zł nie dotyczy wizyt już opłaconych.**

Pacjent zgodził się na konkretne warunki i konkretną kwotę w dniu zakupu. Bez tej zasady zmiana cennika sprawiłaby, że stare zwroty przestałyby zgadzać się z tym, co ludzie faktycznie zapłacili.

**Lista rezerwacji pokazuje 60 pozycji, a kartoteka pacjentów 25 — i obie wprost piszą, ile pozycji ukryły.**

Jak działa system? Fundacja Niepełnoim „to wszystko, co jest”, i prowadzi do wniosków wyciągniętych z połowy danych. Liczba przy każdym filtrze mówi z góry, ile pozycji zobaczysz po kliknięciu, żeby żaden przycisk nie obiecywał czegoś, czego

| pod nim nie ma.

# Powiadomienia i płatności

*Koordinacja fundacji ustala tu, co i kiedy system napisze pacjentowi oraz specjaliście, a także pilnuje pieniędzy: wpłat przy rezerwacji, zwrotów po odwołaniach i wypłat dla specjalistów.*

## Powiadomienia SMS (koordynacja)

Koordinator widzi listę siedmiu wiadomości tekstowych, które system wysyła sam, i cztery liczby na górze: ile jest gotowych treści, ile wiadomości poszło przez ostatnie 30 dni, ile to kosztowało i ile treści nie mieści się w jednej wiadomości. Po kliknięciu w wybraną treść z prawej strony pojawia się rysunek telefonu z gotowym tekstem — dokładnie takim, jaki zobaczy pacjentka na ekranie. Pod spodem system podaje liczbę znaków i mówi, na ile osobno płatnych części rozpadnie się ta wiadomość. Na samym dole jest lista ostatnich wysyłek: przycięty numer telefonu, nazwa wiadomości, ile minut temu poszła i czy dotarła.

- Zawęzić listę do jednej kategorii: przypomnienia, potwierdzenia, zmiany i odwołania, obsługa konta
- Kliknąć w wybraną wiadomość i przeczytać ją w podglądzie telefonu, z podstawionymi przykładową datą, godziną i adresem
- Sprawdzić przy każdej wiadomości, ile ma znaków i na ile płatnych części się rozpada
- Wpisać numer telefonu i wysłać wiadomość testową — w makiecie nic nie wychodzi, pojawia się tylko komunikat
- Przejrzeć ostatnie wysyłki i zobaczyć, która wiadomość nie dotarła

Treści wiadomości tekstowych są tu do czytania, a nie do zmieniania — zmienia je wykonawca, bo każde dopisane zdanie może podnieść rachunek. Numery telefonów na liście wysyłek są przycięte do trzech ostatnich cyfr: koordynator rozpoznaje po nich wysyłkę, a ekran bywa oglądany przy innych osobach.

## Szablony wiadomości e-mail (koordynacja)

Siedem gotowych maili, które system wysyła sam, z informacją, do kogo idzie każdy z nich: do pacjenta, do specjalisty czy do koordynatora. Przy każdym widać, co go uruchamia i ile takich maili poszło przez ostatnie 30 dni, a przy zmienionych — znacznik, że treść różni się od tej, którą fundacja dostała na starcie. Po prawej stronie jest podgląd gotowej wiadomości z podstawionym imieniem, datą, kwotą i adresem — tak, jak zobaczy ją odbiorca. Po wejściu w tryb zmiany zamiast podglądu pojawia się pole na temat i pole na treść.

- Zawęzić listę do jednej kategorii: rezerwacja i płatność, przypomnienia, zmiany i odwołania, konto i limity, rozliczenia
- Przeczytać gotową wiadomość w podglądzie
- Zmienić temat i treść wybranego maila i zapisać zmianę — obowiązuje od następnej wysyłki
- Wstawić do treści imię, datę, godzinę czy kwotę jednym kliknięciem z listy dostępnych pozycji
- Przywrócić treść wyjściową, jeśli zmiana okazała się nietrafiona
- Wysłać próbną wiadomość na własny adres

Maile koordynator zmienia sam, wiadomości tekstowe nie — bo mail nie ma limitu znaków i to w mailach fundacja najczęściej chce coś dopisać. Ceną tej swobody jest ryzyko wysłania maila z napisem „{imie}” do trzystu osób, więc przed zapisem system sprawdza wszystkie takie wstawki i nie pozwala zapisać nazwy, której nie umie podstawić.

Celowo nie ma tu pogrubień, kolorów ani obrazków: zwykły tekst dociera zawsze, rozbudowana grafika potrafi wylądować w spamie albo rozjechać się tak, że nie widać godziny wizyty. Jedna rzecz do ujednolicenia przed

wdrożeniem: mail o odwołaniu przez specjalistę obiecuje zwrot w 3 dni robocze, a okno odwołania po stronie pacjentki mówi o 3–5 dniach roboczych.

piątek, 7 sierpnia 2026, 12:09

## Reguły systemu — część o pieniądzach i powiadomieniach

Jeden ekran, na którym zapada decyzja, jak system ma się zachować bez pytania kogokolwiek o zdanie. U góry listy wyboru z czasami: do kiedy odwołanie jest bezpłatne, ile razy można przełożyć wizytę, jak długo termin jest trzymany podczas płatności. Niżej tabela ośmiu sytuacji, która przy każdej odpowiada na trzy pytania: czy pacjent dostaje zwrot, czy termin wraca do wolnych i czy specjalista dostaje za tę godzinę wynagrodzenie. Jeszcze niżej pieniądze — udział fundacji w wizytach pełnopłatnych, częstotliwość wypłat, kredyt za odsprzedany termin — a na końcu lista siedmiu powiadomień, każde z dwoma przełącznikami: mail i wiadomość tekstowa.

- Ustawić, ile godzin przed wizytą kończy się bezpłatne odwołanie
- Ustawić limit zmian terminu, najbliższy możliwy termin, przerwę między wizytami i czas trzymania terminu podczas płatności
- Ustawić udział fundacji w wizytach pełnopłatnych i niskopłatnych oraz częstotliwość wypłat
- Włączyć lub wyłączyć kredyt dla pacjenta, którego odwołany termin ktoś inny wykupił
- Przy każdym z siedmiu powiadomień włączyć albo wyłączyć mail i wiadomość tekstową
- Zapisać ustawienia

Dwa powiadomienia nie mają przełącznika i nie da się ich wyłączyć: potwierdzenie rezerwacji oraz potwierdzenie odwołania ze zwrotem. To jedyny dowód, jaki pacjent ma na to, że wizyta istnieje i że pieniądze wracają. Druga rzecz: zmiana czasów obowiązuje tylko nowe rezerwacje. Osoba, która już zapłaciła, zgodziła się na konkretne warunki i przesunięcie okna z 24 na 48 godzin nie może jej dotyczyć wstecz.

## Płatność przy rezerwacji

Pacjentka wypełnia dane kontaktowe i zaznacza zgody, a z prawej strony przez cały czas widzi podsumowanie: kto, kiedy, jak długo i ile to kosztuje. Pod podsumowaniem odlicza się czas, przez który termin jest trzymany tylko dla niej, oraz informacja, że zapłacić można kartą, BLIK-iem, Google Pay i Apple Pay, a fundacja nie przechowuje danych karty. Jeśli wizyta jest niskopłatna, w tym samym miejscu pojawia się informacja, która to wizyta z przyznanej puli i co się dzieje po jej wyczerpaniu. Ostatnia zgoda przed przyciskiem zapłaty to zasada odwoływania, wypisana z konkretną datą i godziną, a nie odesłaniem do regulaminu.

- Wpisać imię, adres e-mail i telefon oraz zaznaczyć, czy to pierwsza wizyta
- Napisać kilka zdań dla specjalisty przed wizytą — nieobowiązkowo
- Zaznaczyć założenie konta z hasłem albo zostać przy rezerwacji jako gość
- Zaznaczyć zgody, w tym potwierdzenie zasady bezpłatnego odwołania z podaną datą i godziną
- Przejść do płatności przyciskiem z wypisaną kwotą
- Wrócić i zmienić termin, zanim skończy się odliczanie

Stan puli wizyt niskopłatnych pokazujemy przed zapłatą, a nie dopiero w panelu. Osoba, która wykorzystała pulę, ma się o tym dowiedzieć w chwili wyboru, a nie po zaksięgowaniu przelewu. Odliczanie jest widoczne wprost, w minutach i sekundach — po jego upływie termin wraca do wolnych, więc lepiej, żeby pacjentka to wiedziała, niż żeby dowiedziała się przy próbie zapłaty.

## Potwierdzenie po opłaceniu

Ekran mówi wprost, że wizyta jest zarezerwowana, podaje numer rezerwacji i adres, na który poszło potwierdzenie. Niżej zestawienie: termin, usługa, forma i zapłacona kwota z czterema ostatnimi cyframi karty. Przy wizycie zdalnej od razu widnieje link do rozmowy, przy stacjonarnej — adres gabinetu, piętro i numer domofonu. Osobna ramka wypisuje, co się wydarzy dalej: mail teraz, przypomnienie 24 godziny przed z podaną datą i godziną zamknięcia bezpłatnej zmiany, przypomnienie 2 godziny przed i propozycja kolejnego terminu po wizycie.

- Skopiować link do rozmowy albo odczytać adres gabinetu
- Dodać wizytę do kalendarza w telefonie lub na komputerze
- Przejść do zarządzania rezerwacją
- Umówić od razu kolejną wizytę na ten sam dzień i godzinę za tydzień, dwa albo trzy

Link do rozmowy jest dostępny od razu, a nie dopiero w przypomnieniu dwie godziny przed — pacjent, który go szuka na ostatnią chwilę, dzwoni do fundacji. Kolejne wizyty proponujemy pojedynczo, bez pakietów i serii: każda jest osobno opłacona i osobno odwoływana, więc nie ma czego rozliczać ani zwracać za niewykorzystaną część.

## Wizyty pacjentki — odwołanie, zmiana terminu i zwrot

Lista nadchodzących wizyt, każda z kwotą, sposobem zapłaty i numerem rezerwacji. Przy wizycie, do której zostało więcej niż 24 godziny, widnieje zielona ramka z datą i godziną, do której zmiana i odwołanie są bezpłatne, oraz dwa przyciski. Przy wizycie bliższej niż 24 godziny przycisków nie ma w ogóle — jest wyjaśnienie, że wizyta jest płatna niezależnie od obecności, i przycisk napisania do specjalisty. W oknie odwołania pacjentka widzi zapłaconą kwotę, zasadę zapisaną zwykłym zdaniem i kwotę zwrotu, zanim cokolwiek potwierdzi.

- Przeczytać, do kiedy zmiana i odwołanie są bezpłatne
- Przełożyć termin: wybrać dzień i godzinę z kalendarza tego samego specjalisty, z licznikiem „zmiana 1 z 2”
- Odwołać wizytę po zobaczeniu kwoty zwrotu i podać powód — nieobowiązkowo
- Napisać do specjalisty, gdy do wizyty zostało mniej niż 24 godziny
- Skopiować link do rozmowy albo sprawdzić adres gabinetu
- Przejrzeć historię wcześniejszych wizyt razem ze sposobem zapłaty

Po upływie 24 godzin przyciski znikają, a nie robią się szare. Szary przycisk kusi, żeby go klikać i szukać sposobu obejścia, a potem generuje zgłoszenia „nie działa mi”. Przy zmianie terminu płatność przechodzi na nowy termin i nie pobieramy jej drugi raz — to jest napisane wprost w oknie, bo jest to pierwsze pytanie, jakie ludzie zadają.

## Rezerwacje u koordynatora — co się stało z pieniędzmi

Na górze cztery liczby: wizyty dzisiaj, rezerwacje czekające na płatność, zwroty w toku wraz z kwotą oraz nieobecności z ostatnich 14 dni wraz z kwotą, która została u fundacji. Niżej wyszukiwarka, filtry i tabela wszystkich rezerwacji, gdzie pod każdą kwotą widnieje dopisek mówiący, co się z nią stało: „zwrot do wykonania”, „bez zwrotu” albo „nieopłacone”. Po otwarciu wybranej rezerwacji koordynator dostaje jej pełną historię: kiedy powstała, kiedy zaksięgowano płatność i z jakiej karty, kiedy poszło potwierdzenie, kiedy przypomnienie, a przy odwołaniu — jaka kwota czeka na zwrot.

- Znaleźć rezerwację po numerze albo nazwisku pacjenta
- Zawęzić listę po okresie, specjalistce, usłudze, formie i stanie rezerwacji
- Otworzyć historię pojedynczej rezerwacji i przeczytać, co się z nią działo
- Wysłać potwierdzenie jeszcze raz, gdy pacjent go nie znalazł
- Pobrać zestawienie rezerwacji do arkusza

Nigdzie na tym ekranie nie pada zdanie „zwrot wykonany”. Zwroty klika człowiek w panelu operatora płatności, a system tylko pokazuje listę tego, co się komu należy — więc dopóki ktoś nie kliknie, prawdziwe jest wyłącznie „zwrot do wykonania”. Historia rezerwacji pokazuje tylko to, co już się wydarzyło: nie ma na niej przypomnienia, które dopiero pójdzie, ani płatności przy rezerwacji, która jeszcze czeka na opłacenie.

## Rozliczenia specjalisty

Specjalistka widzi cztery liczby: kwotę do wypłaty za bieżący okres, liczbę godzin w gabinecie, liczbę godzin opłaconych mimo braku pacjenta oraz datę najbliższej wypłaty. Niżej tabela wizyt z tego okresu, gdzie przy każdej stoi kwota opisana jako „dla Ciebie”, i osobna tabela późnych odwołań i nieobecności — rozliczanych tak samo jak wizyty odbyte. Z boku krótka ściągawka, kiedy godzina jest płatna, a kiedy nie, lista przesłanych faktur ze stanem każdej z nich oraz historia wypłat z poprzednich miesięcy. Gdy koordynator poprosił o poprawę faktury, powód widnieje tu od razu, a nie tylko w mailu.

- Zmienić okres rozliczeniowy na poprzedni miesiąc albo bieżący rok
- Pobrać zestawienie dla własnej księgowości
- Przesłać fakturę za miniony miesiąc
- Sprawdzić stan każdej przesłanej faktury i przeczytać, co wymaga poprawy
- Sprawdzić w ściągawce, czy za daną sytuację godzina jest płatna

Nie ma tu kolumny „pacjent zapłacił” ani „udział fundacji”. Specjalistka widzi swoją stawkę, bo tylko na nią ma wpływ — rozbicie każdej wizyty na kwotę pacjenta i potrącenie nie daje jej żadnej decyzji do podjęcia, a zamienia ekran wypłaty w przypomnienie o marży. Pełne rozliczenie widzi wyłącznie koordynator.



## Przesłanie faktury przez specjalistę

Okno mówi, za który miesiąc jest rozliczenie, ile wizyt obejmuje, do kiedy trzeba je przesłać i jaką kwotę wystawić. Pod kwotą stoi wyjaśnienie, skąd się wzięła: to suma stawek za wizyty odbyte w tym okresie razem z godzinami opłaconymi mimo nieobecności pacjenta. Niżej pole na numer faktury i miejsce na wgranie pliku. Na końcu trzy kroki, co się wydarzy dalej: koordynator sprawdza zgodność, przelew wychodzi na konto z profilu, potwierdzenie księgowania przychodzi mailem.

- Wpisać własny numer faktury
- Wgrać plik faktury w formacie PDF, do 10 MB, albo go usunąć i wgrać inny
- Odczytać podpowiedzianą kwotę i porównać ją z własnym wyliczeniem
- Wysłać fakturę — przycisk działa dopiero, gdy jest i numer, i plik

System podpowiada kwotę, ale faktury nie wystawia. Specjaliści rozliczają się na różnych zasadach — działalność, zlecenie, ryczałt — i dokument musi wyjść z ich własnej księgowości. Bez załączonego pliku wysyłka jest zablokowana, bo fundacja potrzebuje dokumentu, a nie samej deklaracji kwoty.

## Faktury specjalistów u koordynatora

Cztery liczby na górze: ile faktur czeka na sprawdzenie i na jaką kwotę, ile jest zaakceptowanych do wypłaty w tym miesiącu, ile wróciło do poprawy i przy ilu kwota nie zgadza się z wyliczeniem systemu. Niżej tabela, w której obok kwoty z faktury stoi znacznik zgodności — albo „zgodna”, albo różnica ze wskazaniem, ile system naliczył. Po otwarciu faktury koordynator widzi sam plik, zestawienie obu kwot, różnicę i zdanie wyjaśniające, co ta różnica najczęściej oznacza. Osobne okno służy do napisania, co konkretnie wymaga poprawy.

- Zawęzić listę do faktur czekających na sprawdzenie, zaakceptowanych, do poprawy albo już opłaconych
- Otworzyć fakturę i podejrzeć plik
- Porównać kwotę z faktury z wyliczeniem systemu i zobaczyć różnicę
- Z zaakceptować fakturę do wypłaty w najbliższej paczce
- Poprosić o korektę, wpisując wprost, czego brakuje — bez wpisanego powodu przycisk nie działa

Stan nazywa się „do poprawy”, a nie „odrzucona”. Odrzucenie brzmi jak zarzut, a w dziewięciu przypadkach na dziesięć chodzi o pomyłkę w rachunku i o człowieka, z którym fundacja chce dalej pracować. Sprawdzanie faktur chroni przede wszystkim specjalistę: kwota bywa niższa od wyliczenia systemu, bo licząc z własnego kalendarza łatwo pominąć godziny opłacone mimo nieobecności pacjenta — automatyczna akceptacja oznaczałaby, że fundacja płaci mniej, niż powinna.

## Zasady obowiązujące w tym obszarze

**Bezpłatne odwołanie i zmiana terminu są możliwe najpóźniej 24 godziny przed wizytą. Później wizyta jest płatna, bez zwrotu i bez możliwości przełożenia.**

Specjalista zablokował tę godzinę wyłącznie dla jednej osoby i w tym czasie nie przyjmie nikogo innego. Doba to tyle, ile realnie potrzeba, żeby ktoś inny zdążył ten termin zająć — przy krótszym czasie godzina po prostu przepada.

Po przekroczeniu 24 godzin przyciski odwołania i zmiany terminu znikają z ekranu, a nie robią się szare. Na ich miejscu pojawia się wyjaśnienie i przycisk napisania do specjalisty.

Szary przycisk kusi, żeby go klikać i szukać obejścia, a potem kończy się telefonem, że system nie działa. Decyzję o wyjątku podejmuje człowiek, nie system, więc zamiast zablokowanego przycisku dajemy drogę do rozmowy.

**Odwołanie wcześniej niż 24 godziny przed wizytą oznacza zwrot całej kwoty. Odwołanie później albo niestawienie się oznacza brak zwrotu, ale specjalista dostaje za tę godzinę wynagrodzenie, a termin i tak wraca do wolnych.**

Specjalista zarezerwował ten czas i nie mógł przyjąć nikogo innego, więc jego wynagrodzenie się nie zmienia. Termin mimo to wypuszczamy, bo zdarza się, że ktoś go jeszcze wykupi — lepiej, żeby godzina się odbyła, niż stała pusta.

Jeżeli po późnym odwołaniu ktoś inny wykupi zwolniony termin, pierwsza osoba dostaje równowartość jako kredyt na kolejną wizytę.

Fundacja nie zarabia dwa razy na jednej godzinie. Specjalista ma tę godzinę opłaconą tak czy inaczej, a różnicę pokrywa fundacja z własnych środków — dla pacjenta w kryzysie finansowym to bywa różnica między kolejną wizytą a jej brakiem.

**Jedną rezerwację można przełożyć 2 razy. Trzecia zmiana wymaga kontaktu ze specjalistą.**

Każde przesunięcie blokuje kolejną godzinę w grafiku i odbiera ją komuś innemu. Trzecia zmiana zwykle znaczy, że ten termin po prostu nie pasuje — wtedy lepiej ustalić nowy razem ze specjalistą niż przesuwać go w nieskończoność.

**Przy rezerwacji przez stronę termin jest trzymany 10 minut. Po tym czasie wraca do wolnych.**

Przez te 10 minut nikt inny nie może zająć tej godziny, więc nie da się jej trzymać w nieskończoność. Dziesięć minut wystarczy na dokończenie płatności kartą albo BLIK-iem, a nie zostawia terminów wiszących bez wpłaty.

**Gdy termin umawia specjalista podczas sesji, pacjent ma 2 dni na opłacenie go z linku wysłanego mailem.**

Ta osoba nie siedzi przy komputerze z kartą w ręce, tylko właśnie wyszła z gabinetu. Dwa dni obejmują weekend i jeden dzień roboczy, więc mieści się w tym także ktoś, kto płaci przelewem po wypłacie.

**Za wizytę płaci się z góry pełną kwotę: 55 zł za konsultację niskopłatną, od 115 do 145 zł za pełnopłatną, 350 zł za diagnozę ADHD, a wsparcie asystenta zdrowienia jest bezpłatne.**

Oplacona wizyta jest wizytą, która się odbywa — przy płatności na miejscu odsetek nieobecności rośnie kilkakrotnie, a każda pusta godzina to godzina zabrana komuś z kolejki.

Zwrot pieniędzy klika człowiek w panelu operatora płatności. System pokazuje wyłącznie listę „zwrot do wykonania” i nigdzie nie napisze, że zwrot już poszedł.

Przy kilkudziesięciu zwrotach miesięcznie ręczne kliknięcie jest tańsze i pewniejsze niż automat, który trzeba pilnować i naprawiać, gdy zwrot się nie powiedzie. Dzięki temu żaden ekran nie obiecuje pacjentowi czegoś, czego nikt jeszcze nie zrobił.

**Pieniądze wracają na tę samą kartę, z której zapłacono, zwykle w 3 do 5 dni roboczych.**

To czas banku i operatora płatności, nie fundacji — moment kliknięcia zwrotu i moment pojawienia się pieniędzy na

konkretnie dwie różne rzeczy. Warto ujednolicić tę liczbę we wszystkich wiadomościach: mail o odwołaniu przez specjalistę mówi dziś o 3 dniach, a okno odwołania o 3 do 5.

**Jedna wiadomość tekstowa mieści 160 znaków, ale z polskimi ogonkami tylko 70. Każda kolejna część to osobna opłata około 8 groszy, a same ogonki dokładają blisko połowę miesięcznego rachunku za wysyłkę.**

Dlatego treści wiadomości tekstowych są krótkie i zmienia je wykonawca po policzeniu kosztu. Nie zalecamy pisania bez ogonków — wiadomość od fundacji pomocowej wygląda wtedy jak spam i to kosztuje więcej niż te złotówki. Tańsza droga to skrócenie zdania.

**W wiadomościach tekstowych nie ma ani słowa o zdrowiu, nazwie usługi ani specjalizacji, a nadawcą jest „Niepodzielni”.**

Wiadomość wyświetla się na zablokowanym ekranie, często przy innych ludziach. Dla części pacjentów sam fakt korzystania z pomocy jest informacją, której nie chcą pokazywać rodzinie ani współpracownikom.

**Kod do logowania bez hasła jest ważny 10 minut.**

Kod, który leży w skrzynce tygodniami, wpuszcza do konta każdego, kto zobaczy telefon albo pocztę. Dziesięć minut wystarczy, żeby przepisać sześć cyfr, i nie wystarczy, żeby ktoś skorzystał z niego później.

**Treści maili koordynator zmienia sam i od razu, treści wiadomości tekstowych zmienia wykonawca.**

Mail nie ma limitu znaków i nie kosztuje za zdanie, a to właśnie w mailach fundacja najczęściej chce coś dopisać: informację o parkingu, zmianę godzin dyżuru, prośbę o dokument. Czekanie na wykonawcę przy każdej takiej drobnostce kończy się tym, że nikt nic nie poprawia i treści się starzeją.

**Dwóch powiadomień nie da się wyłączyć: potwierdzenia rezerwacji i potwierdzenia odwołania ze zwrotem.**

To jedyny dowód, jaki pacjent ma na to, że wizyta istnieje i że pieniądze wracają. Bez niego każda wątpliwość zamienia się w telefon do koordynacji.

**Przypomnienie wychodzi dokładnie 24 godziny przed wizytą, a drugie — 2 godziny przed, z linkiem do rozmowy.**

Pierwsze wypada w momencie zamykania okna bezpłatnej zmiany, więc pacjent dowiaduje się o zasadzie wtedy, kiedy może jeszcze coś z tym zrobić. Bez tego maila zasada 24 godzin generuje same skargi. Drugie oszczędza szukania linku w skrzynce na pięć minut przed spotkaniem.

**Wiadomości tekstowe wysyłamy tylko przy dwóch zdarzeniach: przypomnieniu 2 godziny przed i odwołaniu wizyty przez specjalistę. Reszta idzie mailem.**

To dwie sytuacje, w których wiadomość musi dotrzeć natychmiast, bo pacjent może być już w drodze. Wszystko inne mail obsługuje taniej i bez limitu znaków.

**Zmiana reguł — na przykład przesunięcie okna z 24 na 48 godzin — obowiązuje wyłącznie nowe rezerwacje.**

Pacjent, który już zapłacił, zgodził się na konkretne warunki i zaznaczył to w formularzu z datą i godziną. Zmiana zasad po fakcie byłaby zmianą umowy bez jego wiedzy.

**Fundacja pobiera 20 procent od wizyt pełnopłatnych i nic od niskopłatnych. Specjalista tej liczby nie widzi — w swoim panelu ma wyłącznie kwotę, którą dostanie.**

Rozbicie każdej wizyty na kwotę pacjenta i potrącenie nie daje specjalistcie żadnej decyzji do podjęcia, a zamienia ekran wypłaty w przypomnienie o marży. Pełne zestawienie — wpływ, prowizja, marża — jest po stronie koordynacji.

**Specjalista przesyła fakturę za miniony miesiąc do 10 dnia miesiąca, a wypłata wychodzi po sprawdzeniu przez koordynatora.**

Jak sprawdzić system? Fundacja Niepodzielni  
Krok 1: sprawdzenie systemu, bo kwota z faktury bywa niższa od wyliczenia systemu — licząc z własnego kalendarza łatwo pominąć godziny opłacone mimo nieobecności pacjenta. Warto rozsunąć te dwie daty: dziś zarówno termin

Wątek: Zmiany 2026-12-09

przesłania faktury, jak i termin przelewu przypada na 10 dzień miesiąca, więc faktura złożona ostatniego dnia nie ma kiedy zostać sprawdzona.

**Fundacja dofinansowuje 10 wizyt niskopłatnych na osobę, a jeden specjalista może wystawić 4 terminy niskopłatne tygodniowo.**

Pula dofinansowania jest skończona, więc fundacja steruje nią przy układaniu grafiku, a nie przy rezerwacji — pacjent nigdy nie powinien zobaczyć wolnego terminu i dostać odmowy przy płatności, czyli w najgorszym możliwym momencie. Po wykorzystaniu 10 wizyt nikt nie traci dostępu do pomocy: przechodzi na cenę pełną albo prosi o zwiększenie puli, co rozpatrujemy zwykle tego samego dnia i bez zaświadczeń.

**Pacjent nie widzi w swoim panelu żadnych sum ani historii wydatków — tylko cenę pojedynczej wizyty przed zapłatą.**

Zestawienie „wydałeś dotąd 1400 zł na terapię” nie pomaga nikomu w leczeniu, a części osób realnie utrudnia decyzję o kolejnej wizycie.